AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 14 · OR · ATLAS

ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después

54	20	3
IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES	TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO	PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS»

Módulo 2 · Cirugía y Especialidades · complemento visual del Tomo 14

Índice por tema

Cómo usarlo. Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 14 donde se trata esa imagen o su tema.

Parecidas pero distintas 31

Índice por tipo de imagen 34

Soluciones de la autoevaluación 36

Signos con nombre propio 33

Autoevaluación 35

01 Patología del Oído Externo y Medio

14.1 Otitis Media Aguda (OMA)

01 Tímpano normal 4
02 Otitis media aguda 4

14.2 Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa

03 Otitis media con efusión 5
04 Collera en el tímpano 5
05 Perforación timpánica central 6
06 Colesteatoma 6

14.3 Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

07 Otitis externa difusa 7
08 Otomicosis 7
09 Otohematoma 8
10 Otitis externa maligna 8
11 Mucormicosis rinoorbitaria 9

14.4 Complicaciones de Otitis

12 Mastoiditis: pabellón despegado 9
13 Mastoiditis coalescente en la TAC 10

02 Audiología & Trastornos del Equilibrio

14.5 Evaluación Auditiva

14 Prueba de Weber 10

14.6 Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

15 Schwannoma vestibular en la RM 11
16 Audífono retroauricular 11

14.7 Síndrome Vertiginoso Periférico

17 Maniobra de Epley 12

14.8 Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Síndrome de Ramsay Hunt

18 Parálisis de Bell: lagoftalmos 12
19 Comisura que no se eleva 13
20 Ramsay Hunt: vesículas en la concha 13

03 Rinología & Senos Paranasales

14.9 Rinitis Alérgica vs No Alérgica

21 Facies de rinitis alérgica 14

14.10 Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana

22 Celulitis periorbitaria por etmoiditis 14
23 Absceso subperióstico en la TAC 15

14.11 Epistaxis Anterior vs Posterior

24 Irrigación del tabique 15

14.12 Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal

25 Fractura nasal: laterorrinia 16
26 Hematoma septal bilateral 16
27 Pólipo que llega a la orofaringe 17

04 Faringe, Laringe & Vía Aérea Superior

14.13 Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana

28 Faringitis sin exudado 17
29 Placas en las criptas amigdalinas 18
30 Amigdalitis con exudado 18

14.14 Complicaciones Supurativas

31 Absceso periamigdalino 19
32 Absceso retrofaríngeo en la Rx lateral 19
33 Absceso retrofaríngeo en la TAC 20
34 Absceso retrofaríngeo: Rx y TC 20
35 Absceso parafaríngeo 21

Índice por tema · continuación

14.15 Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil

36 Facies adenoidea 21
37 Amígdalas grado 4 22

14.16 Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales

38 Carcinoma de cuerda vocal 22
39 Nódulos vocales 23
40 Pólipo vocal 23
41 Edema de Reinke 24

14.17 Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda

42 Croup 24
43 Epiglotitis 25
44 Signo del pulgar 25
45 Laringomalacia 26

05 Cuerpos Extraños, Glándulas Salivales & Oncología Cervical

14.18 Cuerpos Extraños en ORL

46 Pila de botón 26
47 Cuerpo extraño en el conducto 27
48 Cuerpo extraño bronquial: inspiración 27

14.19 Patología de Glándulas Salivales

49 Cálculo en el conducto de Wharton 28
50 Sialadenitis supurada 28
51 Tumor parotídeo benigno 29

14.20 Cáncer de Cabeza y Cuello

52 Carcinoma de lengua 29
53 Leucoplaquia 30
54 Masa cervical lateral 30

01 TEMA 14.1 · OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)

FOTO CLÍNICA

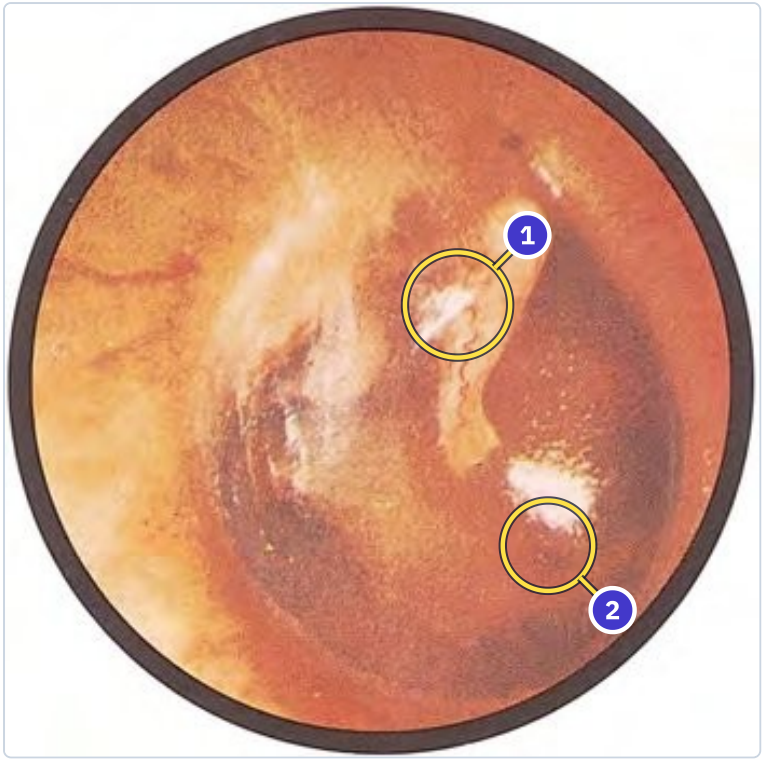


Imagen: Bates, Guía de exploración física, Tabla 7-20

QUÉ TIENES QUE VER

1. Mango del martillo
2. Triángulo luminoso

DIAGNÓSTICO

Tímpano normal

Membrana gris perla, translúcida, con mango del martillo y triángulo luminoso.

CONDUCTA INICIAL

Referencia para comparar.

6.03.1.020 Otitis media aguda — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

OMA: abombado y rojo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 6** Tema 14.1

Clase 14.1 en video

02 TEMA 14.1 · OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)

FOTO CLÍNICA

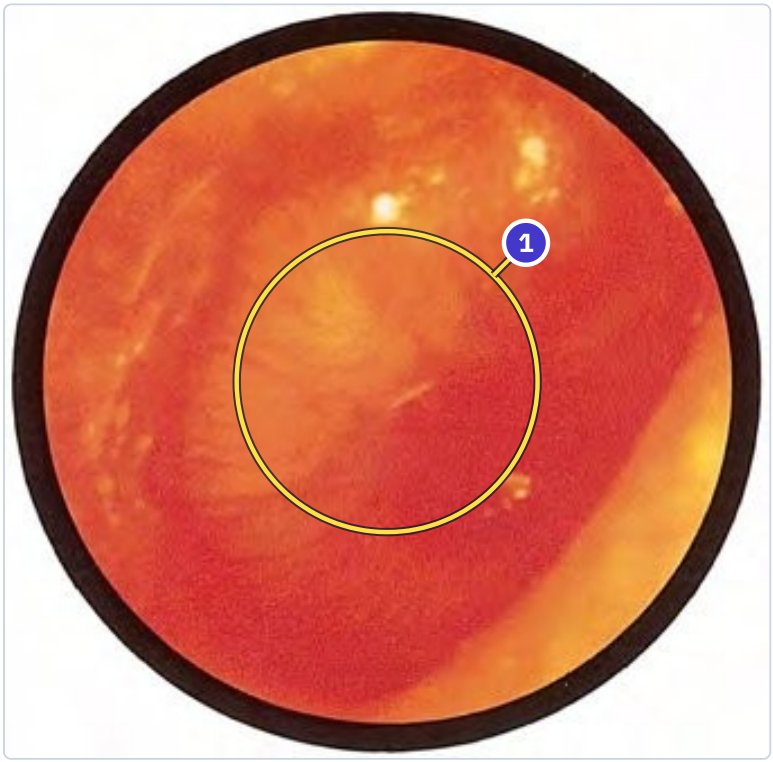


Imagen: Bates, Guía de exploración física, Tabla 7-20

QUÉ TIENES QUE VER

1. Tímpano abombado

DIAGNÓSTICO

Otitis media aguda

Tímpano rojo y abombado, sin relieves.

CONDUCTA INICIAL

Amoxicilina 80–90 mg/kg/día.

6.03.1.020 Otitis media aguda — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

2.01.1.026 Otitis media — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Miringitis por llanto: rojo sin abombamiento.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2024 · P128** «Niño con antecedente de resfrío de 1 semana que inicia con otorrea y otalgia, a la otoscopia secreción purulenta, no se visualiza tímpano:» → **Amoxicilina**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 6** Tema 14.1

Clase 14.1 en video

03 TEMA 14.2 · OTITIS MEDIA CON EFUSIÓN (OME), OMC SIMPLE Y COLESTEATOMATOSA

FOTO CLÍNICA

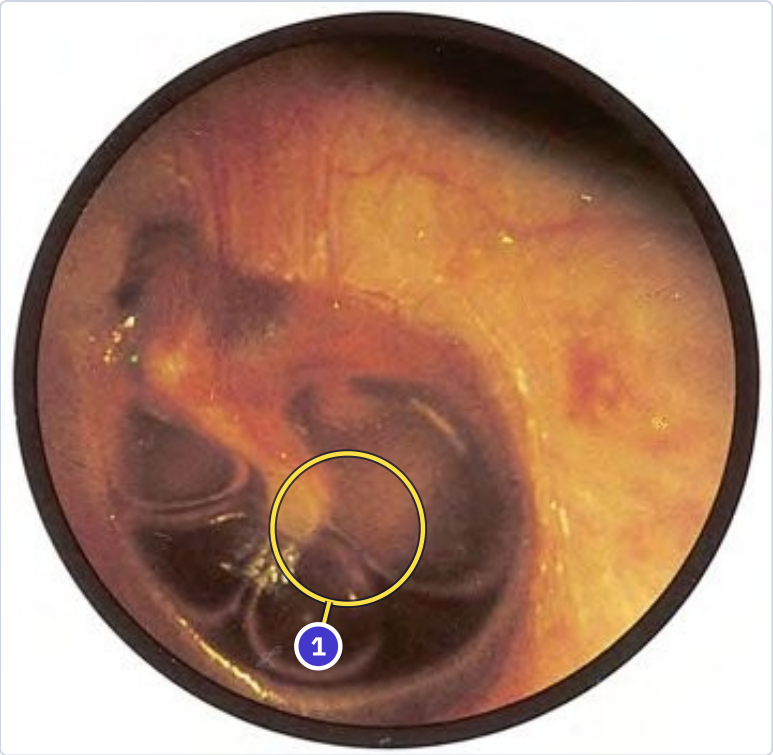


Imagen: Bates, Guía de exploración física, Tabla 7-20

QUÉ TIENES QUE VER

1 Burbujas

DIAGNÓSTICO

Otitis media con efusión

Nivel de líquido y burbujas tras el tímpano.

CONDUCTA INICIAL

Observar 3 meses; colleras si persiste con hipoacusia.

6.03.1.021 Otitis media con efusión

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

OMA: tímpano abombado y dolor.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 11** Tema 14.2

Clase 14.2 en video

04 TEMA 14.2 · OTITIS MEDIA CON EFUSIÓN (OME), OMC SIMPLE Y COLESTEATOMATOSA

FOTO CLÍNICA

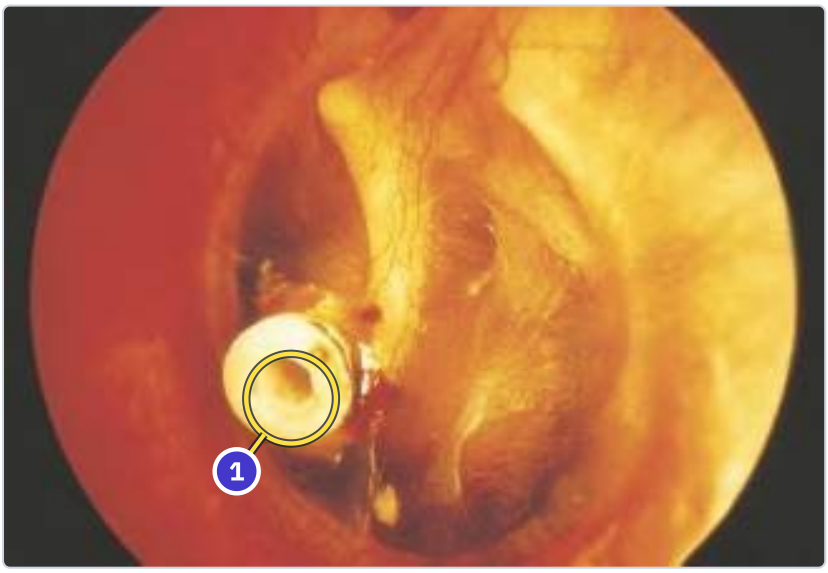


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 46.20

QUÉ TIENES QUE VER

1 Collera

DIAGNÓSTICO

Collera en el tímpano

Tubo de ventilación.

CONDUCTA INICIAL

OME persistente con hipoacusia.

6.03.1.021 Otitis media con efusión

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cuerpo extraño.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 11** Tema 14.2

Clase 14.2 en video

05 TEMA 14.2 · OTITIS MEDIA CON EFUSIÓN (OME), OMC SIMPLE Y COLESTEATOMATOSA

FOTO CLÍNICA

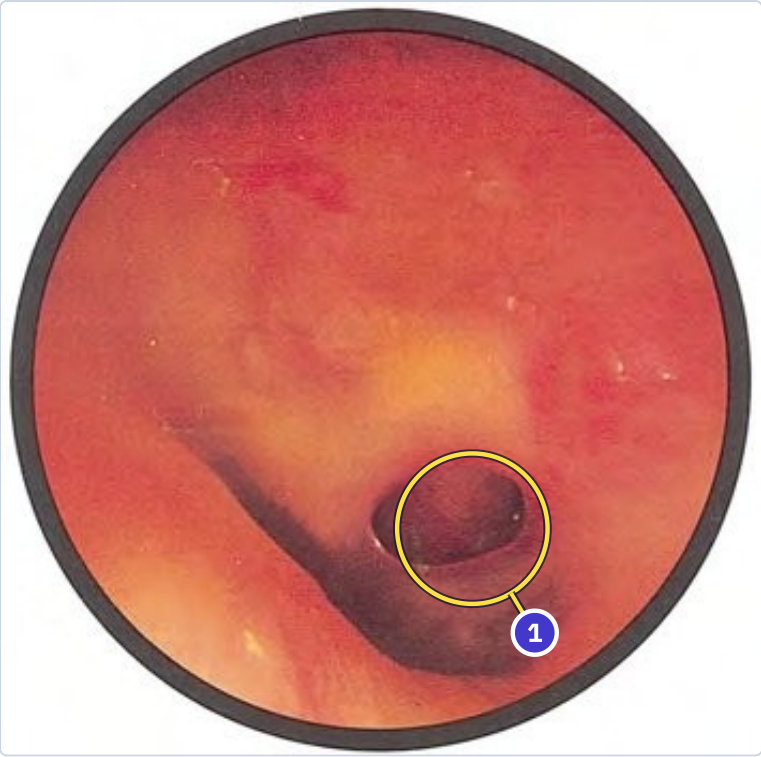


Imagen: Bates, Guía de exploración física, Tabla 7-20

QUÉ TIENES QUE VER

1 Perforación

DIAGNÓSTICO

Perforación timpánica central

Orificio central con borde del tímpano.

CONDUCTA INICIAL

OMC simple: evitar agua; timpanoplastía.

6.03.1.022 Otitis media crónica y complicaciones
Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Perforación marginal: riesgo de colesteatoma.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P148 «Un paciente de 47 años, con antecedente de perforación timpánica derecha de larga data, presenta otalgia y otorrea de dos días de evolución. Al…» → **Ciprofloxacino tópico**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 11** Tema 14.2

Clase 14.2 en video

06 TEMA 14.2 · OTITIS MEDIA CON EFUSIÓN (OME), OMC SIMPLE Y COLESTEATOMATOSA

FOTO CLÍNICA

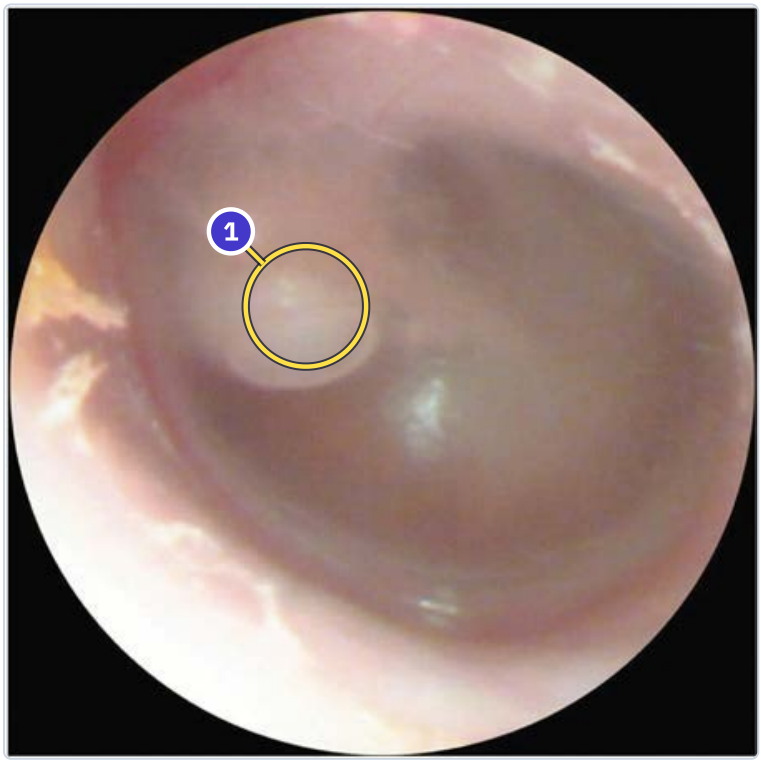


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 5122

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa nacarada

DIAGNÓSTICO

Colesteatoma

Masa blanca nacarada detrás de la membrana timpánica.

CONDUCTA INICIAL

TAC de oídos y cirugía.

6.03.1.022 Otitis media crónica y complicaciones
Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

6.03.4.005 TAC de oídos sin medio de contraste
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Timpanoesclerosis: placa blanca en el tímpano.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 12** Tema 14.2

Clase 14.2 en video

07 TEMA 14.3 · OTITIS EXTERNA DIFUSA VS OTITIS EXTERNA MALIGNA EN DIABÉTICOS

FOTO CLÍNICA

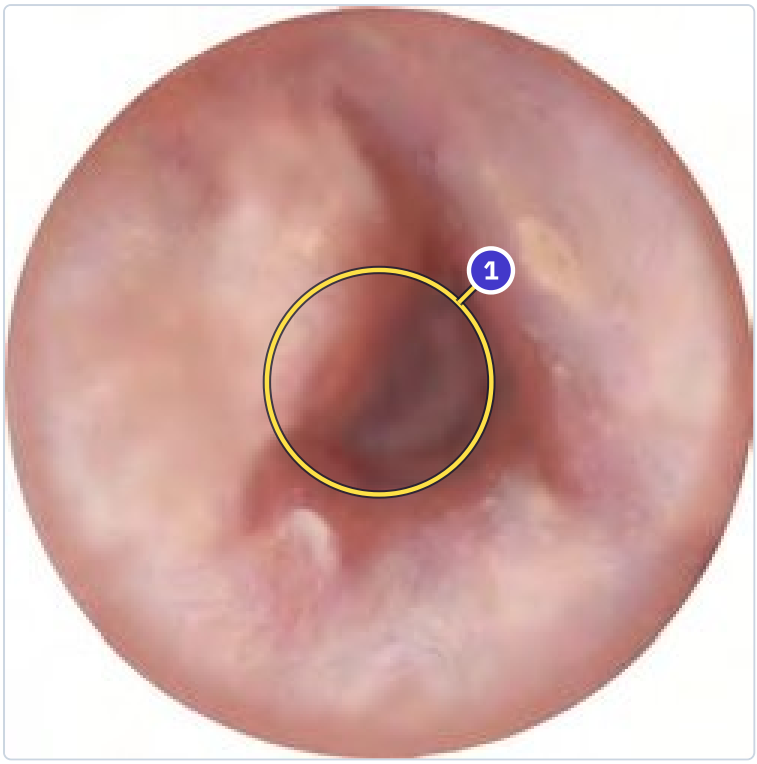


Imagen: Bates, Guía de exploración física, Fig. 7-43

QUÉ TIENES QUE VER

1 Conducto edematoso

DIAGNÓSTICO

Otitis externa difusa

Conducto edematoso y estrecho.

CONDUCTA INICIAL

Gotas con antibiótico y corticoide; dolor al traccionar el pabellón.

6.03.1.019 Otitis externa

Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

OMA: tracción indolora.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P160 «Un niño de 6 años presenta prurito en el oído derecho desde hace 3 días, al que ayer se agregó otalgia intensa. Al examen físico, presenta dolor...» → **O22s externa**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 15** Tema 14.3

Clase 14.3 en video

08 TEMA 14.3 · OTITIS EXTERNA DIFUSA VS OTITIS EXTERNA MALIGNA EN DIABÉTICOS

FOTO CLÍNICA

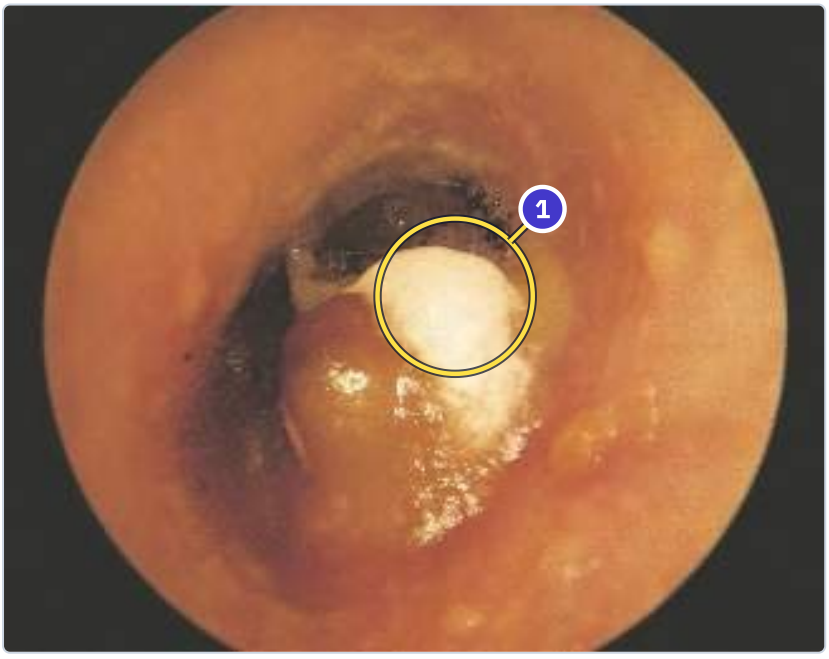


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 46.11

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hifas

DIAGNÓSTICO

Otomicosis

Masa blanquecina algodonosa en el conducto.

CONDUCTA INICIAL

Aseo y antifúngico tópico.

6.03.1.019 Otitis externa

Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Tapón de cerumen.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 15** Tema 14.3

Clase 14.3 en video

09 TEMA 14.3 · OTITIS EXTERNA DIFUSA VS OTITIS EXTERNA MALIGNA EN DIABÉTICOS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 727

QUÉ TIENES QUE VER

1 Otohematoma

DIAGNÓSTICO

Otohematoma

Colección bajo el pericondrio del pabellón.

CONDUCTA INICIAL

Drenaje y vendaje compresivo: evita la oreja en coliflor.

6.03.2.014	Otohematoma	Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar
6.03.5.005	Drenaje de otohematoma	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Pericondritis: dolor y fiebre.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 15** Tema 14.3

Clase 14.3 en video

10 TEMA 14.3 · OTITIS EXTERNA DIFUSA VS OTITIS EXTERNA MALIGNA EN DIABÉTICOS

FOTO CLÍNICA

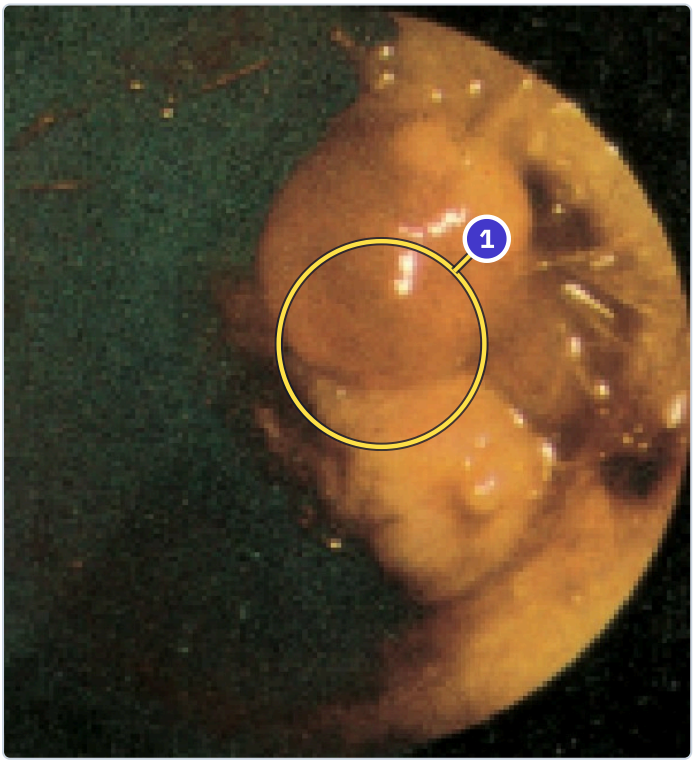


Imagen: Bull, Color Atlas of ENT Diagnosis, 4.ª ed., p. 69

QUÉ TIENES QUE VER

1 Granulación

DIAGNÓSTICO

Otitis externa maligna

Tejido de granulación en el piso del conducto.

CONDUCTA INICIAL

Diabético: ciprofloxacino EV y TAC.

6.03.1.019	Otitis externa	Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar
1.02.1.014	Pié diabético y otras infecciones en diabetes	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Otitis externa difusa.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2024 · P93 «DM con polineuropatía, dedos en garra, hiperqueratosis, con test de monofilamento alterado, pulsos disminuidos, conducta:» → **Mejorar calzado**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 16** Tema 14.3

Clase 14.3 en video

11 TEMA 14.3 · OTITIS EXTERNA DIFUSA VS OTITIS EXTERNA MALIGNA EN DIABÉTICOS

FOTO CLÍNICA

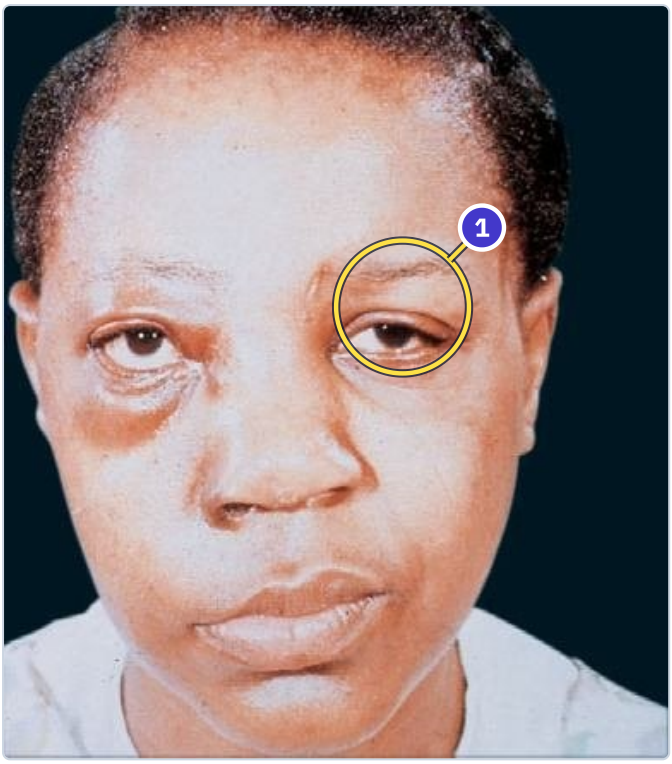


Imagen: Fitzpatrick 7.ª ed., p. 1882

QUÉ TIENES QUE VER

1 Edema periorbitario

DIAGNÓSTICO

Mucormicosis rinoorbitaria

Proptosis, edema facial y parálisis facial en una diabética.

CONDUCTA INICIAL

Anfotericina B y desbridamiento urgente.

1.02.1.014 **Pié diabético y otras infecciones en diabetes**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Celulitis orbitaria bacteriana.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 16** Tema 14.3

Clase 14.3 en video

12 TEMA 14.4 · COMPLICACIONES DE OTITIS

FOTO CLÍNICA

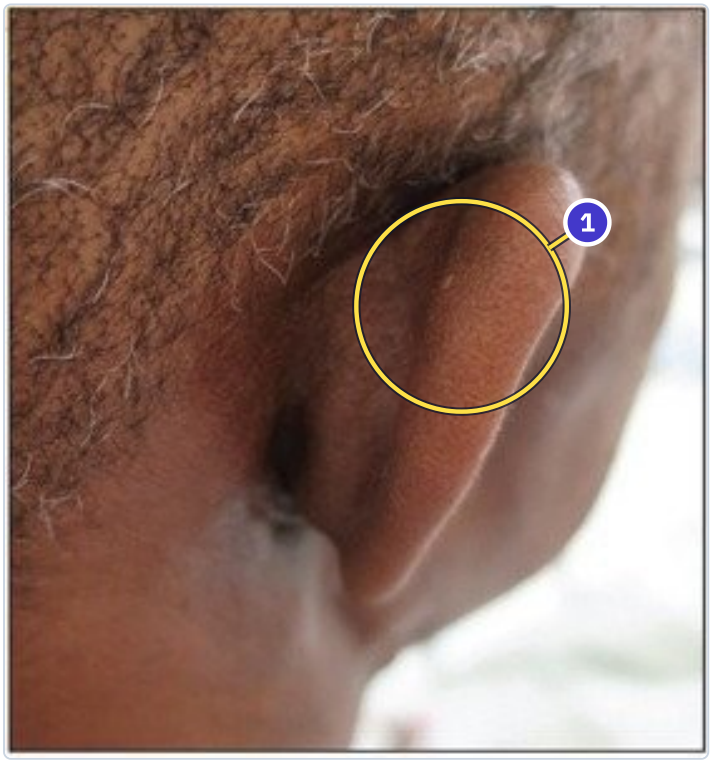


Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 229

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pabellón despegado

DIAGNÓSTICO

Mastoiditis: pabellón despegado

Oreja desplazada hacia adelante.

CONDUCTA INICIAL

Antibióticos EV y TAC; drenaje si hay absceso.

6.03.2.001 **Absceso mastoídeo de otitis media aguda y crónica**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Otitis externa.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 20** Tema 14.4

Clase 14.4 en video

13 TEMA 14.4 · COMPLICACIONES DE OTITIS

IMAGEN RADIOLÓGICA

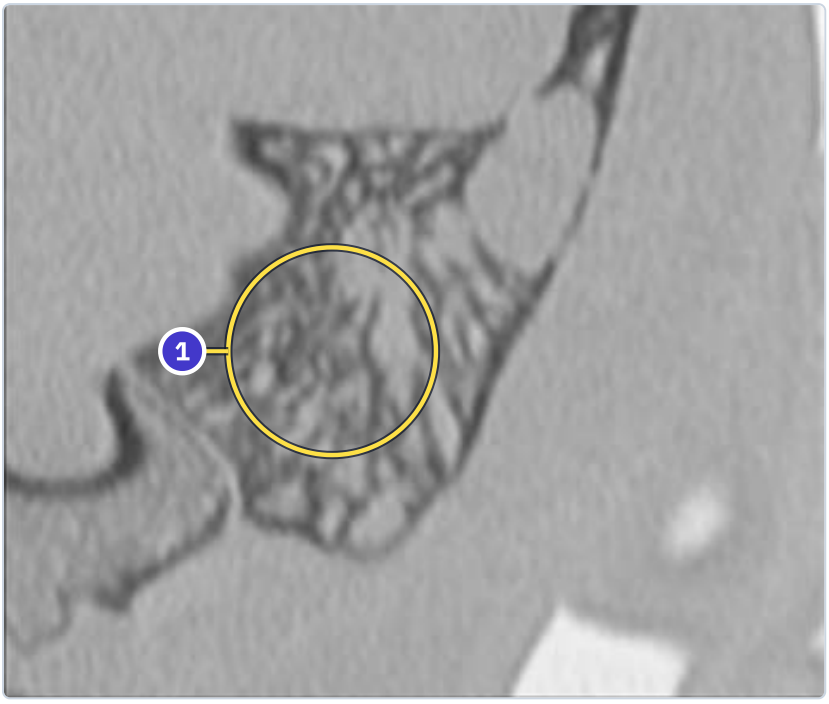


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Mastoides

DIAGNÓSTICO

Mastoiditis coalescente en la TAC

Celdas mastoideas destruidas.

CONDUCTA INICIAL

Cirugía (mastoidectomía).

6.03.2.001	Absceso mastoídeo de otitis media aguda y crónica	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
6.03.4.005	TAC de oídos sin medio de contraste	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Mastoides neumatizada normal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 20** Tema 14.4

Clase 14.4 en video

14 TEMA 14.5 · EVALUACIÓN AUDITIVA

FOTO CLÍNICA

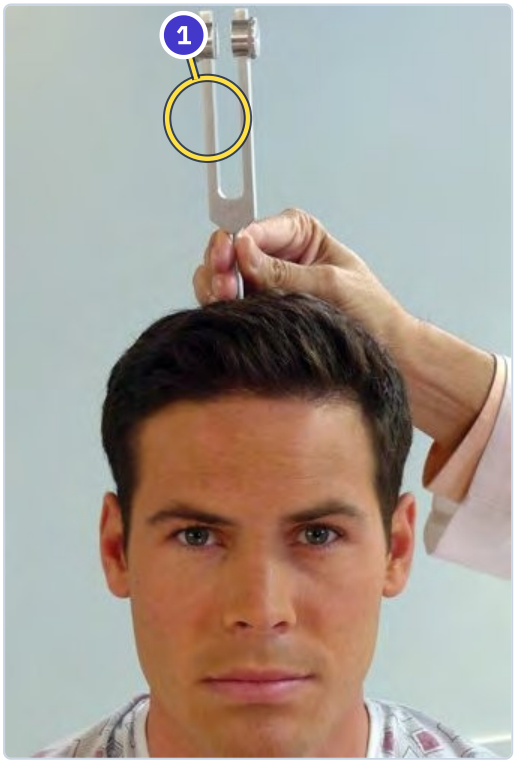


Imagen: Bates, Guía de exploración física, Fig. 7-44

QUÉ TIENES QUE VER

1 Diapasón

DIAGNÓSTICO

Prueba de Weber

Diapasón en la línea media del cráneo.

CONDUCTA INICIAL

Lateraliza al oído enfermo en la conductiva y al sano en la sensorioneural.

6.03.1.007	Diagnóstico diferencial de hipoacusias de transmisión	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
6.03.4.006	Audiometría básica	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Rinne: compara aérea con ósea.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P35** «Una paciente de 48 años consulta por hipoacusia bilateral de 10 años de evolución, progresiva, que aumentó especialmente durante su último...» → **Otoesclerosis**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 28** Tema 14.5

Clase 14.5 en video

15 TEMA 14.6 · HIPOACUSIA SENSORIONEURAL SÚBITA, TRAUMA ACÚSTICO Y PRESBIACUSIA

IMAGEN RADIOLÓGICA

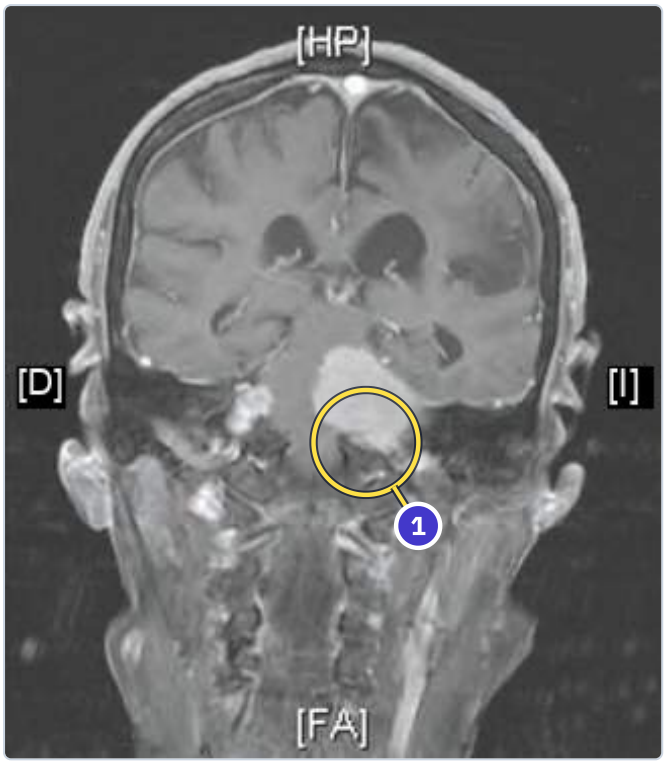


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 687

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa

DIAGNÓSTICO

Schwannoma vestibular en la RM

Masa del ángulo pontocerebeloso.

CONDUCTA INICIAL

Hipoacusia unilateral: RM.

6.03.4.011 **Estudio de VIII par**
examen/procedimiento

6.03.1.008 **Diagnóstico diferencial de hipoacusias sensorioneurales**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Meningioma.

PREGUNTA REAL **Enero 2023 · P136** «Paciente con hipoacusia y tinnitus, examen otoneurológico normal. ¿Cuál es el examen a solicitar?» → **Audiometría**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 30** Tema 14.6

Clase 14.6 en video

16 TEMA 14.6 · HIPOACUSIA SENSORIONEURAL SÚBITA, TRAUMA ACÚSTICO Y PRESBIACUSIA

FOTO CLÍNICA

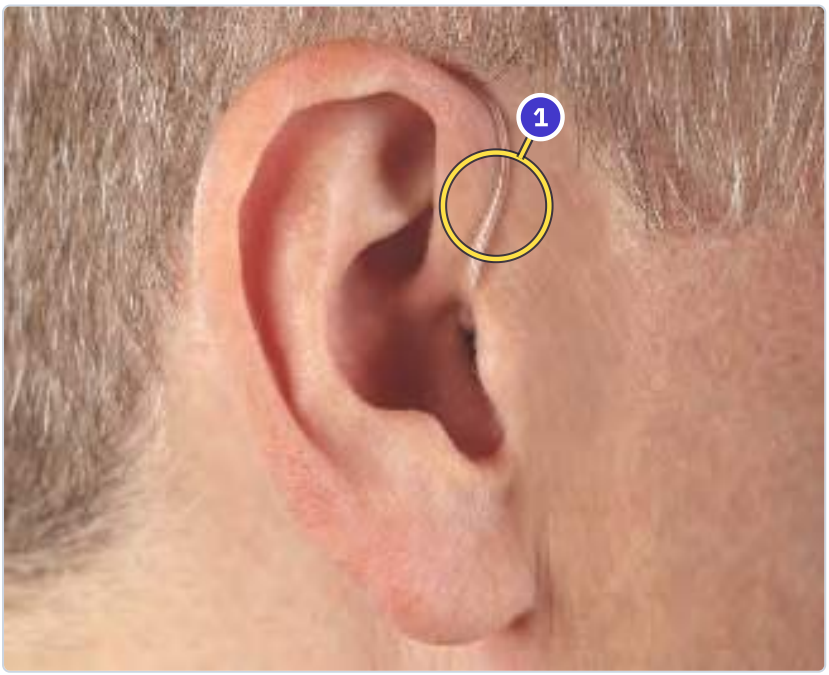


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 734

QUÉ TIENES QUE VER

1 Audífono

DIAGNÓSTICO

Audífono retroauricular

Presbiacusia.

CONDUCTA INICIAL

Presbiacusia: audífono.

6.03.1.008 **Diagnóstico diferencial de hipoacusias sensorioneurales**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Tapón de cerumen.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 30** Tema 14.6

Clase 14.6 en video

17 TEMA 14.7 · SÍNDROME VERTIGINOSO PERIFÉRICO

ESQUEMA

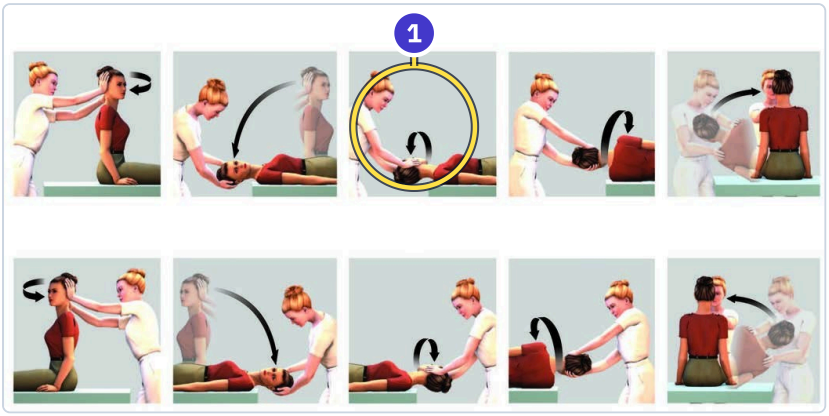


Imagen: Harrison 21.ª ed., Fig. 22-1

QUÉ TIENES QUE VER

1 Secuencia

DIAGNÓSTICO

Maniobra de Epley

Giros de cabeza para reponer los otolitos.

CONDUCTA INICIAL

VPPB del canal posterior.

6.03.1.029 **Síndrome vertiginoso**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.10.1.025 **Síndromes vertiginosos periféricos**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Ménière: vértigo con hipoacusia y tinnitus.

PREGUNTA REAL **Julio 2025 · P154** «Paciente de 50 años con episodios de vértigo rotatorio, tinnitus unilateral fluctuante e hipoacusia neurosensorial ipsilateral. Los síntomas…» → **Enfermedad de Ménière**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 33** Tema 14.7

Clase 14.7 en video

18 TEMA 14.8 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS SÍNDROME DE RAMSAY HUNT

FOTO CLÍNICA

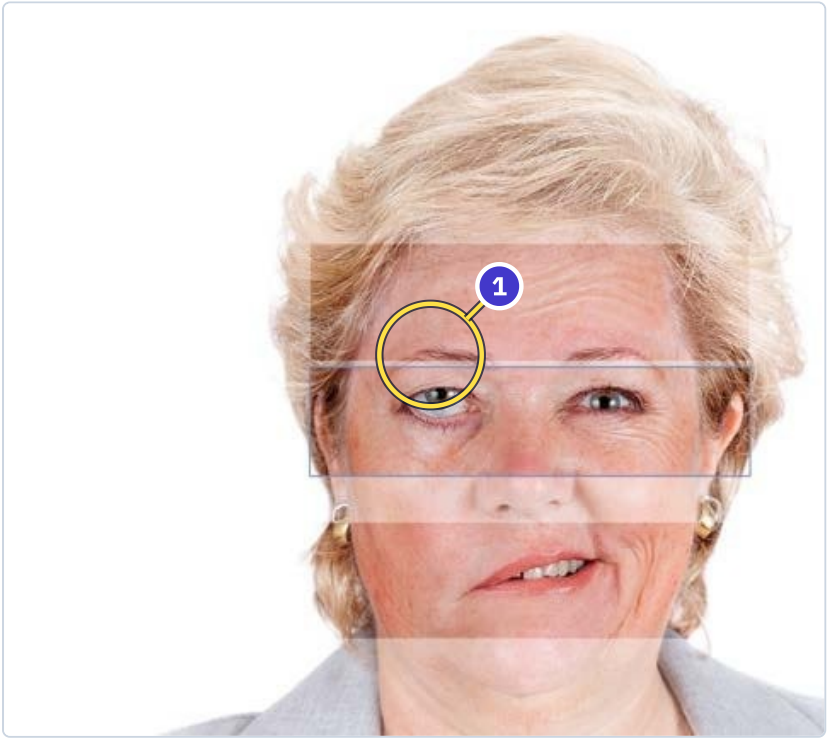


Imagen: Manual AMIR Otorrinolaringología, p. 29

QUÉ TIENES QUE VER

1 Lagoftalmos

DIAGNÓSTICO

Parálisis de Bell: lagoftalmos

El ojo no cierra del lado afectado.

CONDUCTA INICIAL

Prednisona y protección ocular.

1.10.1.016 **Parálisis facial periférica**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Central: cierra el ojo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 39** Tema 14.8

Clase 14.8 en video

19 TEMA 14.8 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS SÍNDROME DE RAMSAY HUNT

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 46.30a

QUÉ TIENES QUE VER

1 Comisura caída

DIAGNÓSTICO

Comisura que no se eleva

Desviación de la boca al sonreír.

CONDUCTA INICIAL

Parálisis facial periférica.

1.10.1.016 **Parálisis facial periférica**
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Central: solo la mitad inferior.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA p. 39 Tema 14.8

Clase 14.8 en video

20 TEMA 14.8 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS SÍNDROME DE RAMSAY HUNT

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 46.30b

QUÉ TIENES QUE VER

1 Vesículas

DIAGNÓSTICO

Ramsay Hunt: vesículas en la concha

Vesículas y costras en el pabellón.

CONDUCTA INICIAL

Valaciclovir y prednisona.

1.10.1.009 **Herpes zoster**
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

1.10.1.016 **Parálisis facial periférica**
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Otitis externa.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P5** «Una mujer de 64 años consulta por dolor intercostal intenso de 3 semanas de evolución, que fue antecedido por la aparición de lesiones…» → **Pregabalina**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA p. 39 Tema 14.8

Clase 14.8 en video

21 TEMA 14.9 · RINITIS ALÉRGICA VS NO ALÉRGICA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bates, Guía de exploración clínica, p. 945

QUÉ TIENES QUE VER

1 Ojeras

DIAGNÓSTICO

Facies de rinitis alérgica

Ojeras alérgicas y boca abierta.

CONDUCTA INICIAL

Corticoide intranasal.

6.03.1.001	Alergia nasosinusal — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo
2.01.1.103	Rinitis alérgica — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Facies adenoidea.

PREGUNTA REAL **Julio 2013 · P146** «Un paciente de 8 años de edad, con historia de un año de evolución de rinorrea mucopurulenta bilateral intermitente asociado a prurito y en…» → **Antihistamínicos orales**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 47** Tema 14.9

Clase 14.9 en video

22 TEMA 14.10 · RINOSINUSITIS AGUDA VIRAL VS BACTERIANA

FOTO CLÍNICA

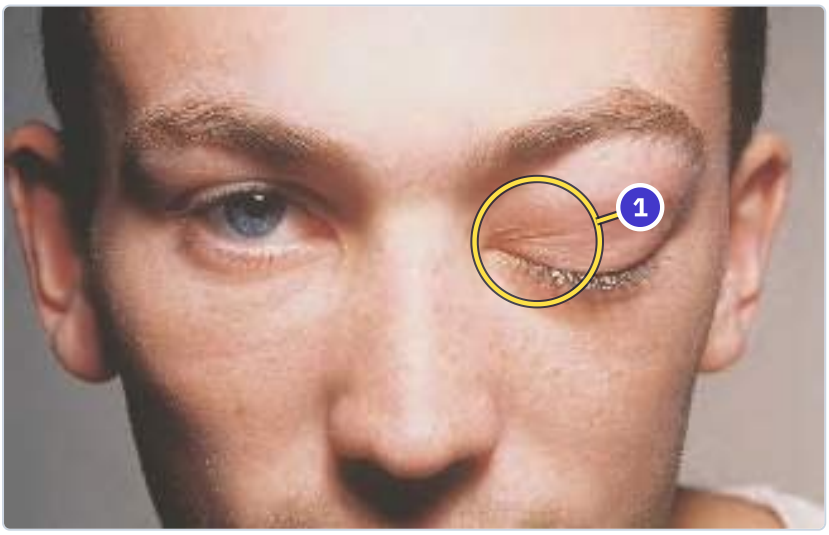


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 46.47

QUÉ TIENES QUE VER

1 Párpado edematoso

DIAGNÓSTICO

Celulitis periorbitaria por etmoiditis

Edema palpebral.

CONDUCTA INICIAL

Proptosis u oftalmoplejía: TAC y antibióticos EV.

2.01.1.005	Celulitis periorbitaria — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
2.01.1.029	Sinusitis — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Conjuntivitis.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2017 · P122** «Una niña de 4 años presenta un cuadro catarral, con abundante rinorrea. Evoluciona con eritema y, dolor periocular derecho, asociado a proptosis….» → **Celulitis orbitaria**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 50** Tema 14.10

Clase 14.10 en video

23 TEMA 14.10 · RINOSINUSITIS AGUDA VIRAL VS BACTERIANA

IMAGEN RADIOLÓGICA

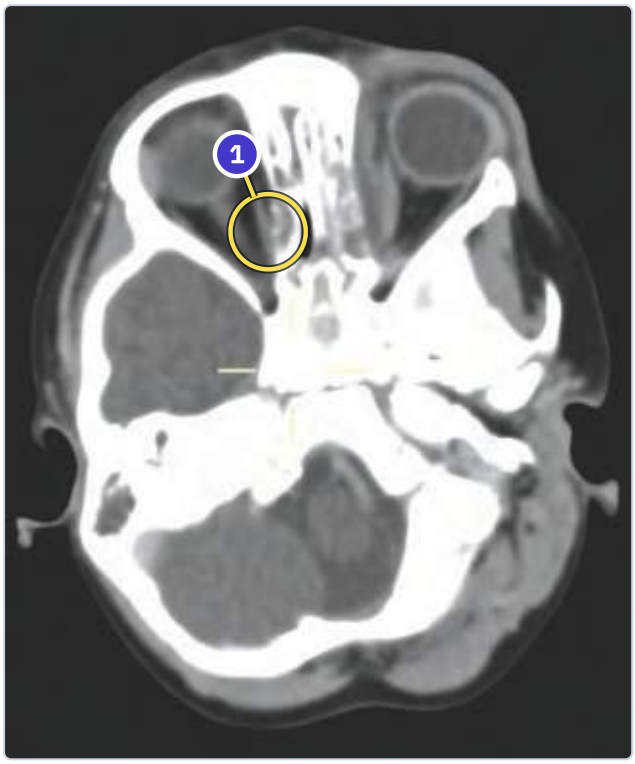


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 46.48

QUÉ TIENES QUE VER

1 Absceso

DIAGNÓSTICO

Absceso subperióstico en la TAC

Colección en la pared medial de la órbita.

CONDUCTA INICIAL

Drenaje quirúrgico.

2.01.1.005 **Celulitis periorbitaria**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

6.03.4.003 **TAC de cavidades perinasales**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Celulitis preseptal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 50** Tema 14.10

Clase 14.10 en video

24 TEMA 14.11 · EPISTAXIS ANTERIOR VS POSTERIOR

ESQUEMA

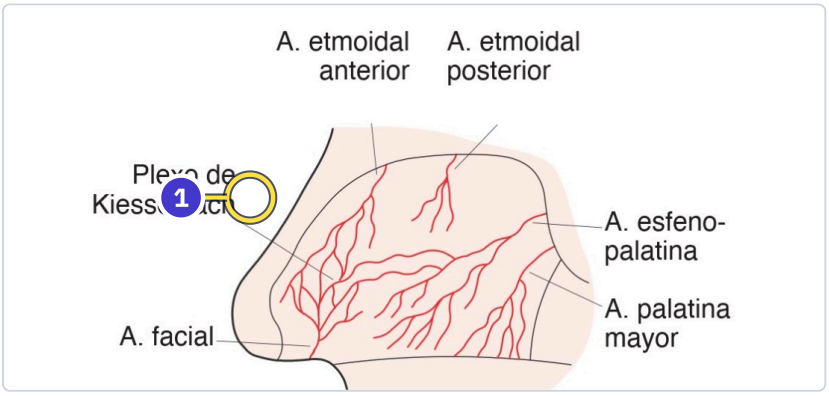


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 46.36

QUÉ TIENES QUE VER

1 Plexo de Kiesselbach

DIAGNÓSTICO

Irrigación del tabique

Plexo de Kiesselbach.

CONDUCTA INICIAL

Epistaxis anterior: compresión y cauterización.

6.03.1.012 **Epistaxis leve**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

6.03.5.012 **Taponamiento nasal anterior**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Epistaxis posterior: esfenopalatina.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 54** Tema 14.11

Clase 14.11 en video

25 TEMA 14.12 · POLIPOSIS NASAL, DESVIACIÓN SEPTAL Y FRACTURA NASAL

FOTO CLÍNICA

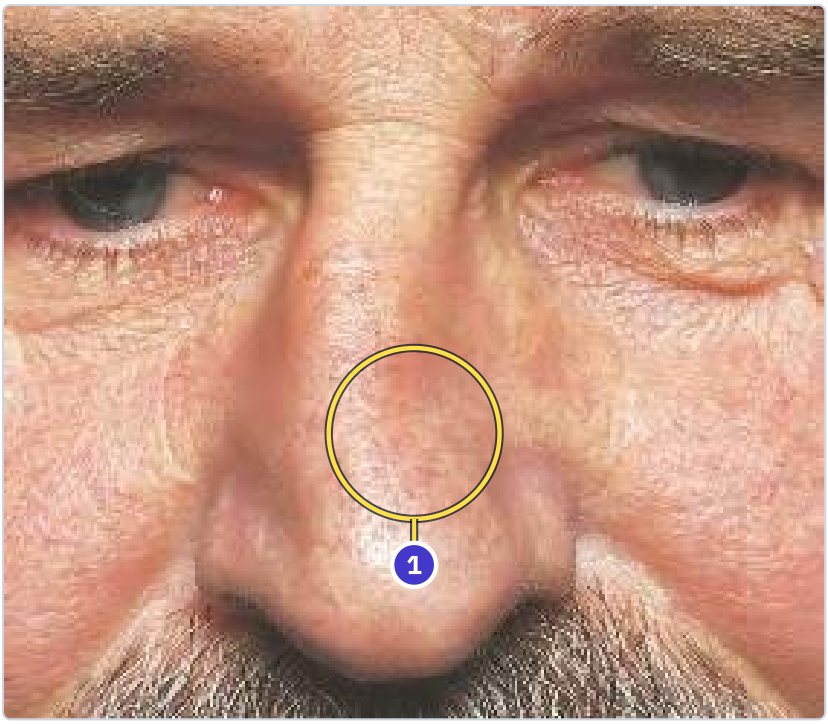


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 46.37

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nariz desviada

DIAGNÓSTICO

Fractura nasal: laterorrinia

Desviación de la pirámide nasal.

CONDUCTA INICIAL

Reducción en los primeros días.

6.03.2.012 **Fractura nasal reciente**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Edema sin fractura.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 59** Tema 14.12

Clase 14.12 en video

26 TEMA 14.12 · POLIPOSIS NASAL, DESVIACIÓN SEPTAL Y FRACTURA NASAL

FOTO CLÍNICA

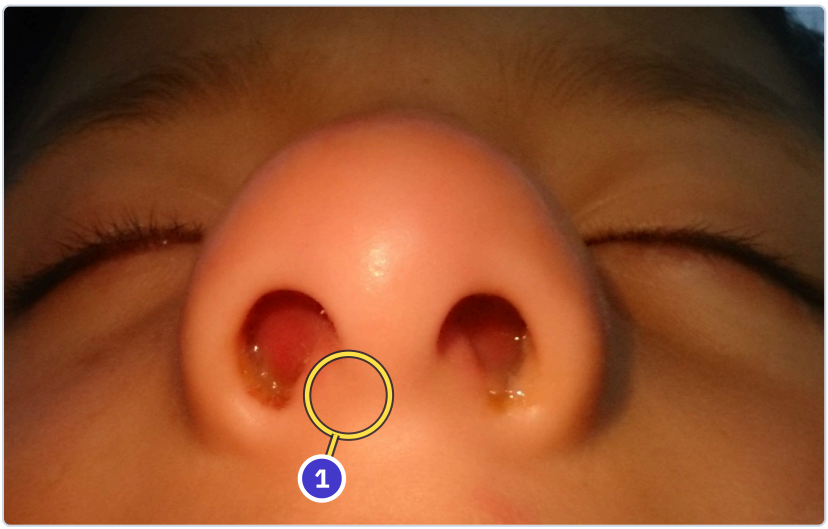


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Tabique abombado

DIAGNÓSTICO

Hematoma septal bilateral

Abombamiento rojo del tabique.

CONDUCTA INICIAL

Drenaje urgente: evita la nariz en silla de montar.

6.03.2.013 **Hematoma nasoseptal**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

6.03.5.004 **Drenaje de hematoma nasoseptal**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Desviación septal.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2019 · P168** «Un paciente de 28 años presenta un pelotazo en la cara, hace 5 días, con golpe en la nariz. Evoluciona con dolor, edema, obstrucción nasal y…» → **Drenaje quirúrgico con bisturí**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 59** Tema 14.12

Clase 14.12 en video

27 TEMA 14.12 · POLIPOSIS NASAL, DESVIACIÓN SEPTAL Y FRACTURA NASAL

FOTO CLÍNICA

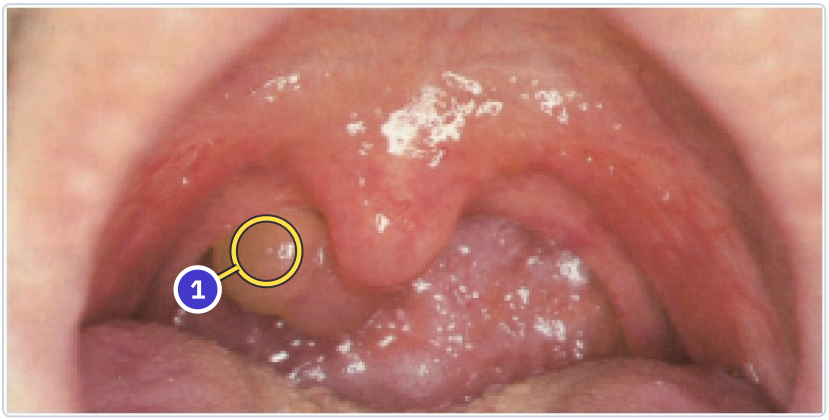


Imagen: Color Atlas of ENT Diagnosis (Bull), p. 158

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pólipo

DIAGNÓSTICO

Pólipo que llega a la orofaringe

Masa lisa detrás del velo.

CONDUCTA INICIAL

Poliposis: corticoide; cirugía endoscópica.

6.03.1.024 **Poliposis nasal**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Tumor nasofaríngeo.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2019 · P58 «Un paciente, con antecedente de rinitis alérgica, presenta obstrucción nasal marcada, asociada varios episodios de sinusitis en el último tiempo….» → **Iniciar prednisona oral 1 mg/Kg/día por 7 días**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA
p. 59
Tema 14.12

Clase 14.12 en video

28 TEMA 14.13 · FARINGOAMIGDALITIS AGUDA BACTERIANA

FOTO CLÍNICA

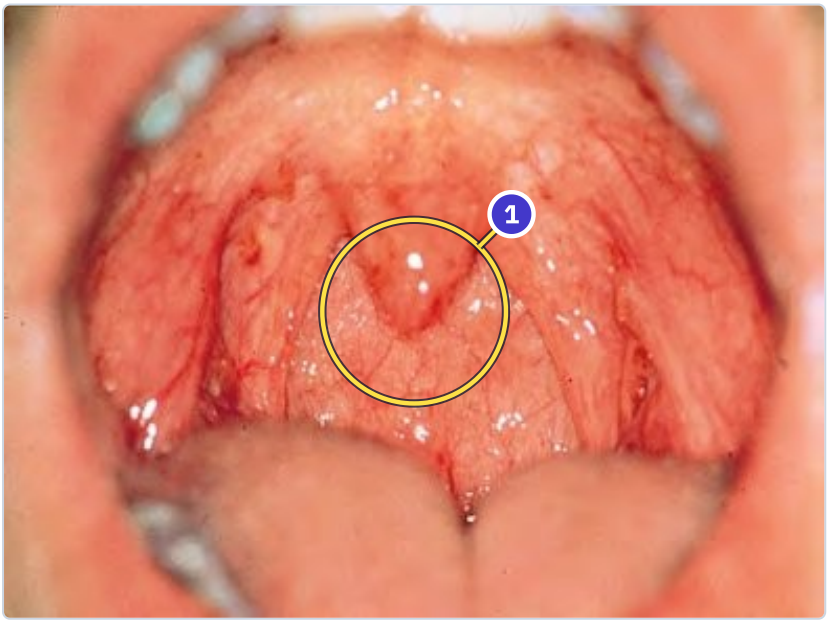


Imagen: Bates, Guía de exploración física, Tabla 7-23

QUÉ TIENES QUE VER

1 Faringe eritematosa

DIAGNÓSTICO

Faringitis sin exudado

Faringe roja sin placas.

CONDUCTA INICIAL

Viral: sintomáticos.

2.01.1.023 **Faringoamigdalitis**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

2.01.1.027 **Resfrío común**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Estreptocócica: exudado y adenopatía.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2019 · P110 «Un niño de 18 meses presenta dolor de garganta y fiebre de 2 días de evolución de hasta 39,0°C, asociado a irritabilidad, malestar general y…» → **Adenovirus**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA
p. 68
Tema 14.13

Clase 14.13 en video

29 TEMA 14.13 · FARINGOAMIGDALITIS AGUDA BACTERIANA

FOTO CLÍNICA

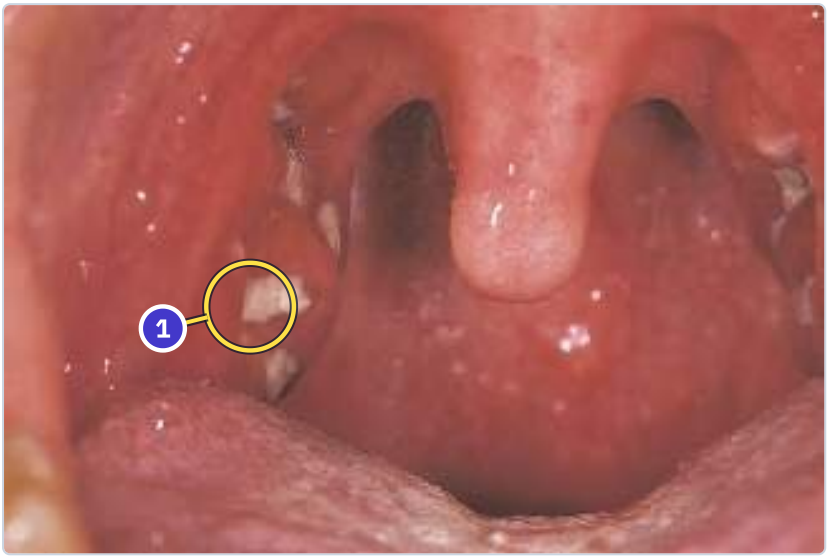


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 47.21

QUÉ TIENES QUE VER

1 Placas

DIAGNÓSTICO

Placas en las criptas amigdalinas

Exudado blanco en las criptas.

CONDUCTA INICIAL

Centor/McIsaac; penicilina benzatina.

2.01.1.023 Faringoamigdalitis — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Mononucleosis: placas grandes y esplenomegalia.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 68** Tema 14.13

Clase 14.13 en video

30 TEMA 14.13 · FARINGOAMIGDALITIS AGUDA BACTERIANA

FOTO CLÍNICA

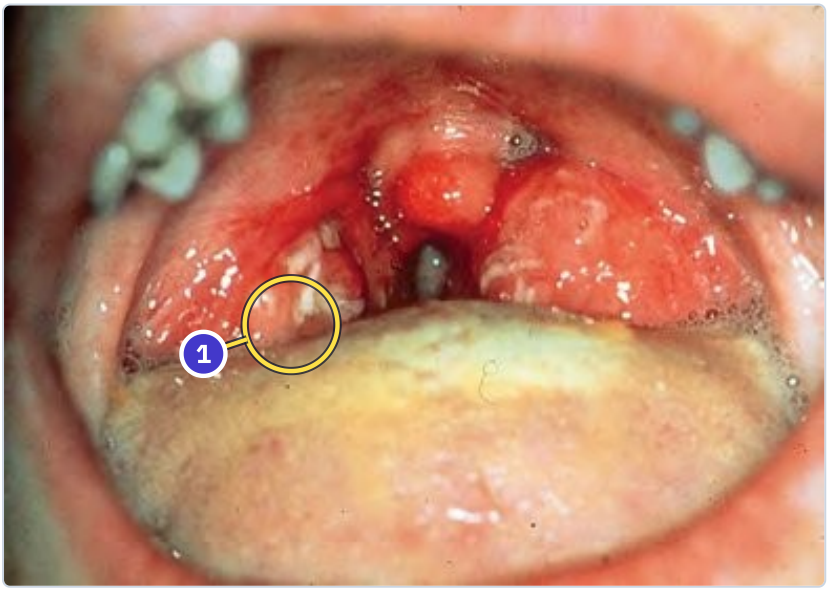


Imagen: Bates, Guía de exploración física, Tabla 7-23

QUÉ TIENES QUE VER

1 Exudado

DIAGNÓSTICO

Amigdalitis con exudado

Amígdalas rojas con exudado.

CONDUCTA INICIAL

Penicilina 10 días.

2.01.1.023 Faringoamigdalitis — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

1.04.1.025 Síndrome mononucleósico — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Difteria: membrana gris adherente.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2025 · P54** «Un paciente de 23 años consulta por fiebre de 7 días de evolución asociada a odinofagia intensa y malestar general. Al examen físico se observa…» → **Mononucleosis infecciosa**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 68** Tema 14.13

Clase 14.13 en video

31 TEMA 14.14 · COMPLICACIONES SUPURATIVAS

FOTO CLÍNICA

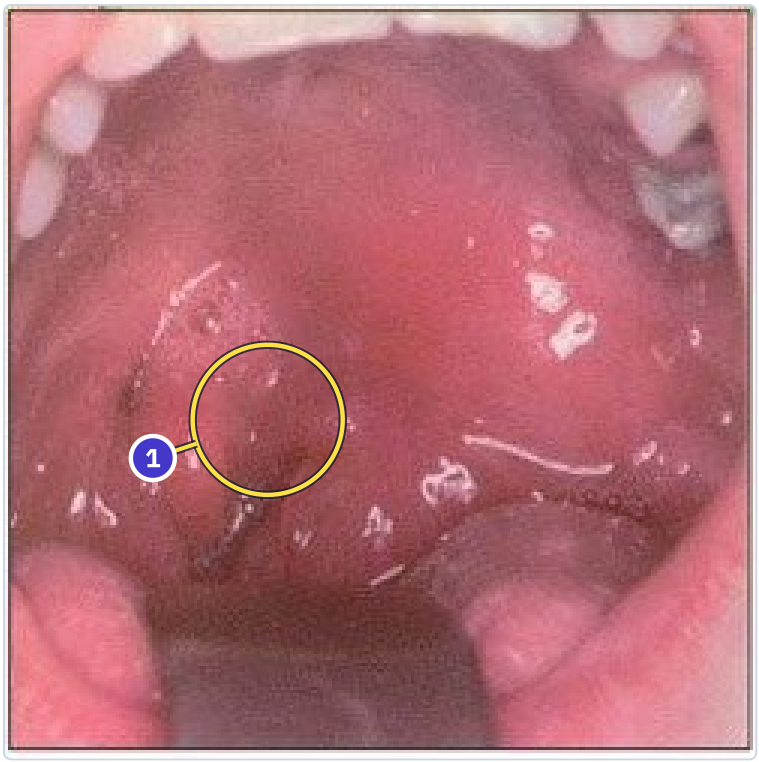


Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 259

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pilar abombado

DIAGNÓSTICO

Absceso periamigdalino

Pilar abombado y úvula desviada.

CONDUCTA INICIAL

Punción-drenaje y antibióticos.

6.03.2.002	Absceso periamigdalino — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo
6.03.5.002	Drenaje de absceso periamigdaliano — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Amigdalitis: sin desviación de la úvula.

PREGUNTA REAL

Julio 2017 · P170 «Un paciente de 23 años consulta por odinofagia intensa, asociada a fiebre, que han empeorado y que y en el último tiempo se agrega dificultades…» → **Absceso periamigdalino**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 73** Tema 14.14

Clase 14.14 en video

32 TEMA 14.14 · COMPLICACIONES SUPURATIVAS

IMAGEN RADIOLÓGICA

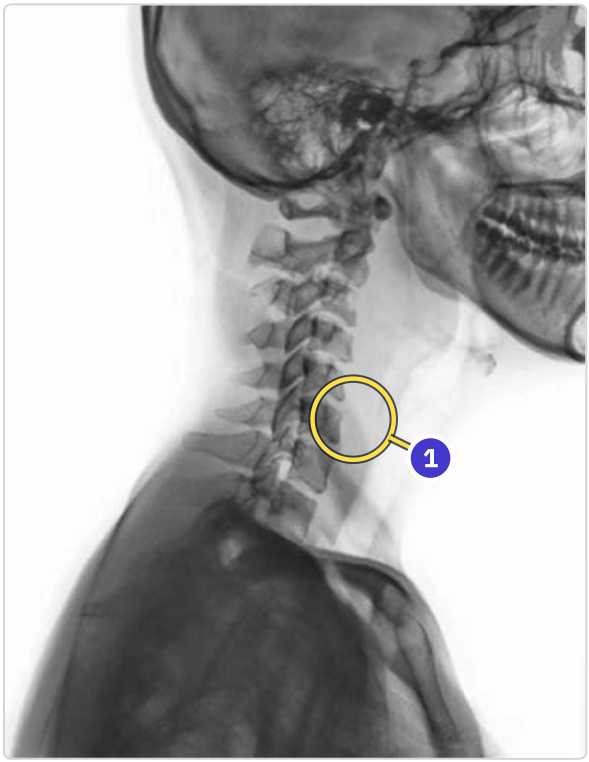


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 3217

QUÉ TIENES QUE VER

1 Espacio prevertebral

DIAGNÓSTICO

Absceso retrofaríngeo en la Rx lateral

Espacio prevertebral ensanchado.

CONDUCTA INICIAL

TAC con contraste y drenaje.

6.03.2.004	Absceso retrofaríngeo — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Rx normal en llanto.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 73** Tema 14.14

Clase 14.14 en video

33 TEMA 14.14 · COMPLICACIONES SUPURATIVAS

IMAGEN RADIOLÓGICA

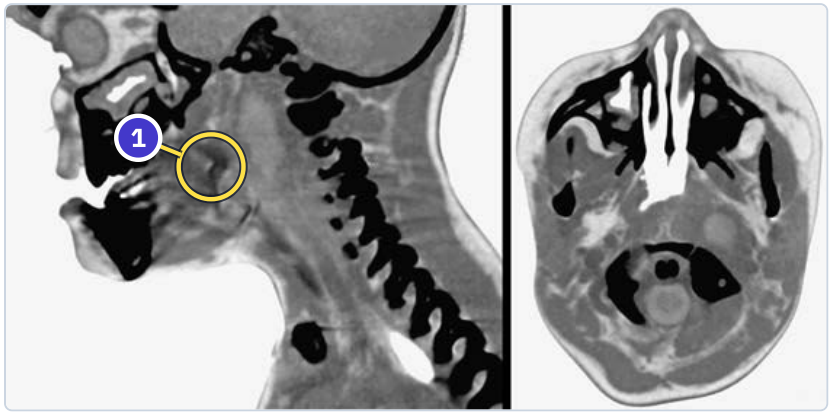


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 3217

QUÉ TIENES QUE VER

1 Colección

DIAGNÓSTICO

Absceso retrofaríngeo en la TAC

Colección retrofaríngea en sagital y axial.

CONDUCTA INICIAL

Drenaje quirúrgico.

6.03.2.004 Absceso retrofaríngeo
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

6.03.4.004 TAC cervical con contraste
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Absceso parafaríngeo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 73** Tema 14.14

Clase 14.14 en video

34 TEMA 14.14 · COMPLICACIONES SUPURATIVAS

IMAGEN RADIOLÓGICA

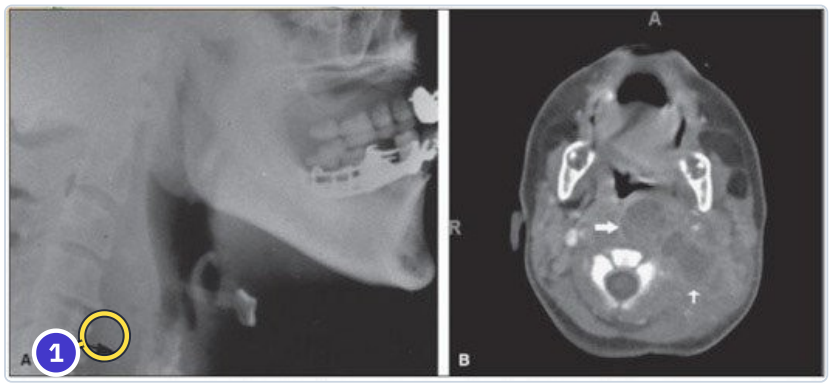


Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 261

QUÉ TIENES QUE VER

1 Espacio ensanchado

DIAGNÓSTICO

Absceso retrofaríngeo: Rx y TC

Espacio prevertebral ensanchado (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Niño menor de 5 años con tortícolis y fiebre.

6.03.2.004 Absceso retrofaríngeo
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Meningitis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 73** Tema 14.14

Clase 14.14 en video

35 TEMA 14.14 · COMPLICACIONES SUPURATIVAS

IMAGEN RADIOLÓGICA

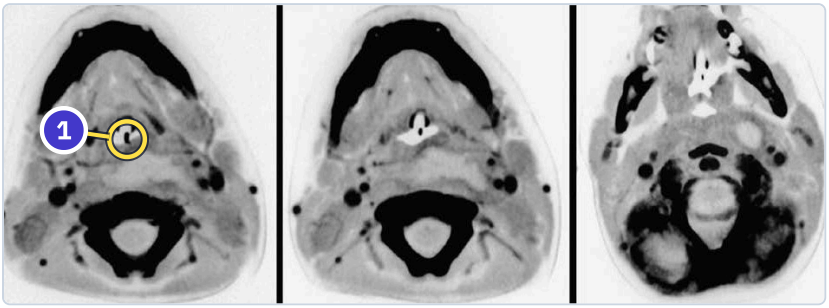


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22nd ed., p. 3217

QUÉ TIENES QUE VER

1 Colección

DIAGNÓSTICO

Absceso parafaríngeo

Colección con realce periférico.

CONDUCTA INICIAL

Antibióticos EV y drenaje.

6.03.2.003	Absceso profundo de cuello	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
6.03.4.004	TAC cervical con contraste	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Adenopatía.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 75** Tema 14.14

Clase 14.14 en video

36 TEMA 14.15 · HIPERTROFIA ADENOTONSILAR Y SAHOS INFANTIL

FOTO CLÍNICA

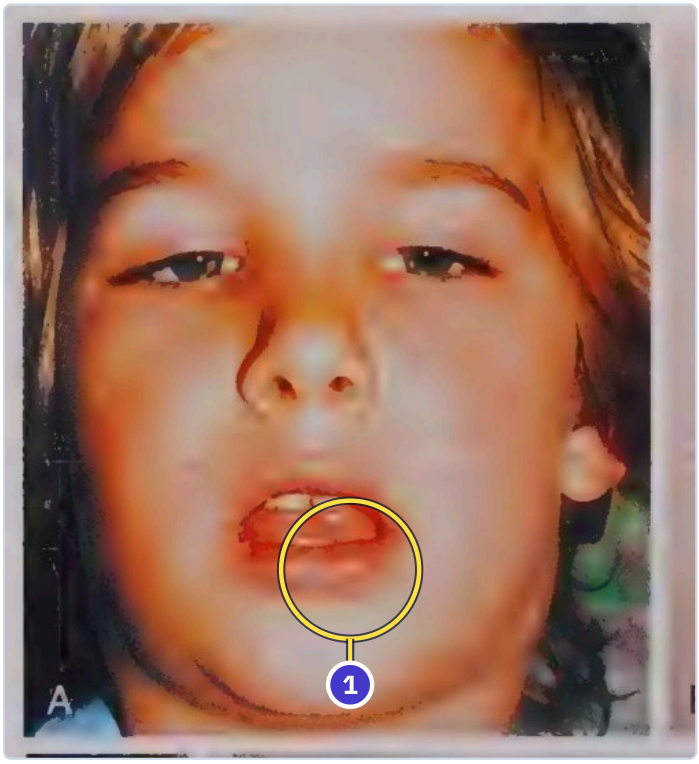


Imagen: Zitelli and Davis' Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, p. 952

QUÉ TIENES QUE VER

1 Boca abierta

DIAGNÓSTICO

Facies adenoidea

Boca abierta y cara alargada.

CONDUCTA INICIAL

Rx de cavum; adenoidectomía si hay SAHOS.

6.03.1.028	Síndrome respirador bucal	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo
2.01.1.100	Hipertrofia adenoidea/amigdalina	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Rinitis alérgica.

PREGUNTA REAL — **Julio 2017 · P48** «Un niño de 7 años, respirador bucal es traído por su madre. No presenta apnea del sueño, ni infecciones a repetición. Al examen físico, no tiene…» → **Observar evolución y controlar ambulatoriamente**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 78** Tema 14.15

Clase 14.15 en video

37 TEMA 14.15 · HIPERTROFIA ADENOTONSILAR Y SAHOS INFANTIL

FOTO CLÍNICA

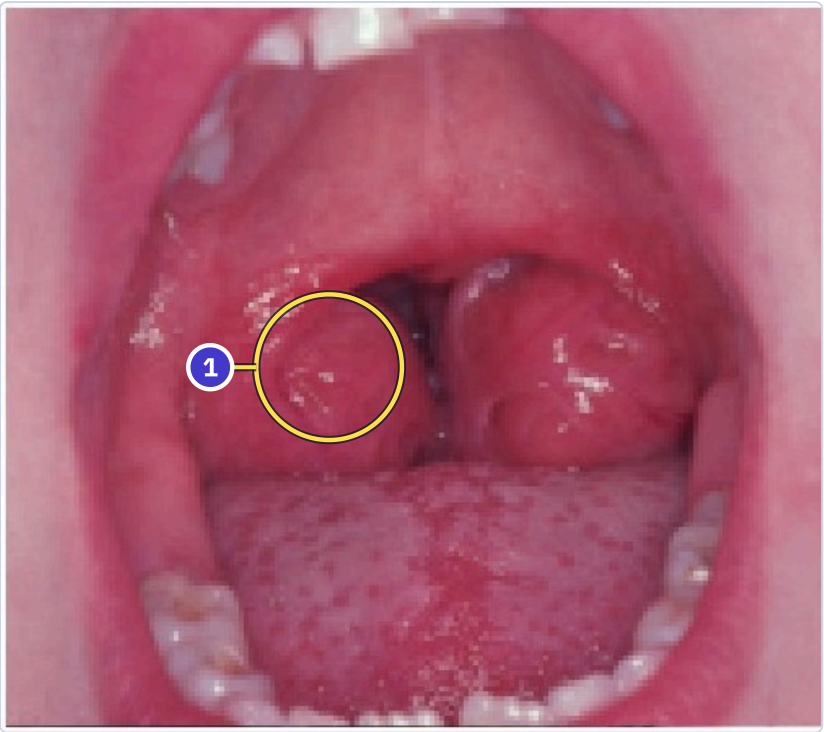


Imagen: Color Atlas of ENT Diagnosis (Bull), p. 200

QUÉ TIENES QUE VER

1 Amígdalas

DIAGNÓSTICO

Amígdalas grado 4

Casi se tocan en la línea media.

CONDUCTA INICIAL

Con SAHOS: amigdalectomía.

2.01.1.100	Hipertrofia adenoidea/amigdalina	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
6.03.1.027	Síndrome de apnea del sueño	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Absceso periamigdalino.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 78** Tema 14.15

Clase 14.15 en video

38 TEMA 14.16 · DISFONÍA CRÓNICA Y PATOLOGÍA BENIGNA DE CUERDAS VOCALES

ENDOSCOPÍA

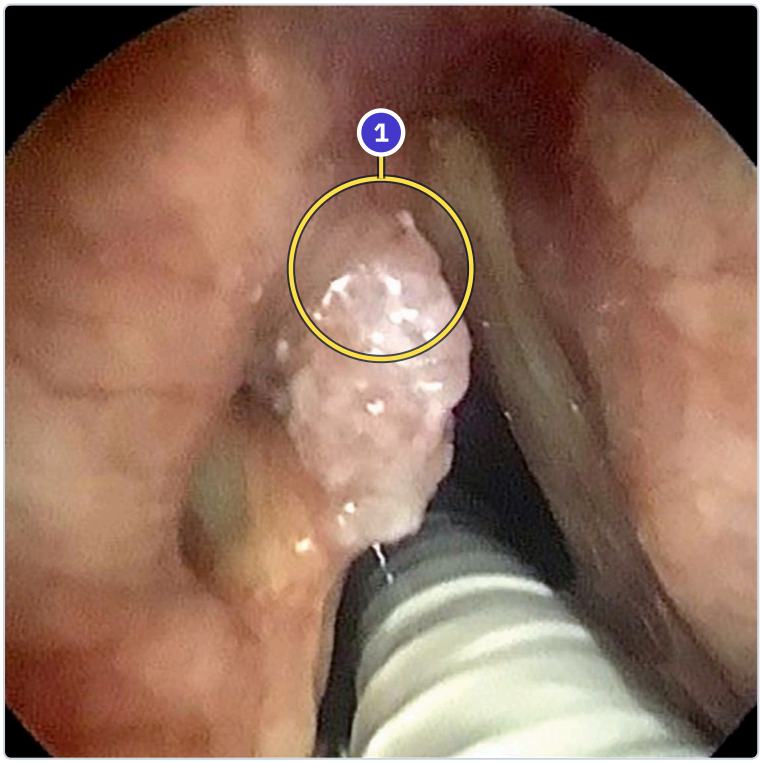


Imagen: Kumar and Clark's Clinical Medicine, p. 640

QUÉ TIENES QUE VER

1 Tumor

DIAGNÓSTICO

Carcinoma de cuerda vocal

Lesión exofítica de la cuerda.

CONDUCTA INICIAL

Disfonía > 3 semanas en fumador: nasofibrolaringoscopía.

6.03.1.005	Cáncer laríngeo e hipofaríngeo	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
6.03.1.010	Disfonías crónicas	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pólipo.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P7 «Un paciente de 66 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por otalgia derecha, de algunos meses de evolución, asociado a odinofagia y…» → **Cáncer de hipofaringe**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 82** Tema 14.16

Clase 14.16 en video

39 TEMA 14.16 · DISFONÍA CRÓNICA Y PATOLOGÍA BENIGNA DE CUERDAS VOCALES

ENDOSCOPÍA

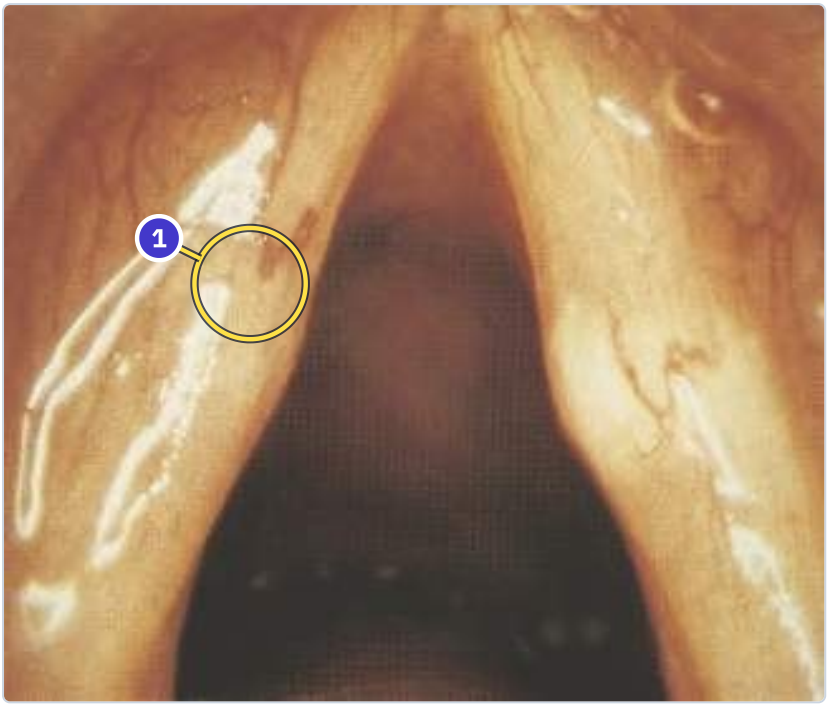


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 771

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nódulo

DIAGNÓSTICO

Nódulos vocales

Nódulos bilaterales simétricos.

CONDUCTA INICIAL

Fonoterapia.

6.03.1.010 Disfonías crónicas

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pólipo: unilateral.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 82** Tema 14.16

Clase 14.16 en video

40 TEMA 14.16 · DISFONÍA CRÓNICA Y PATOLOGÍA BENIGNA DE CUERDAS VOCALES

ENDOSCOPÍA

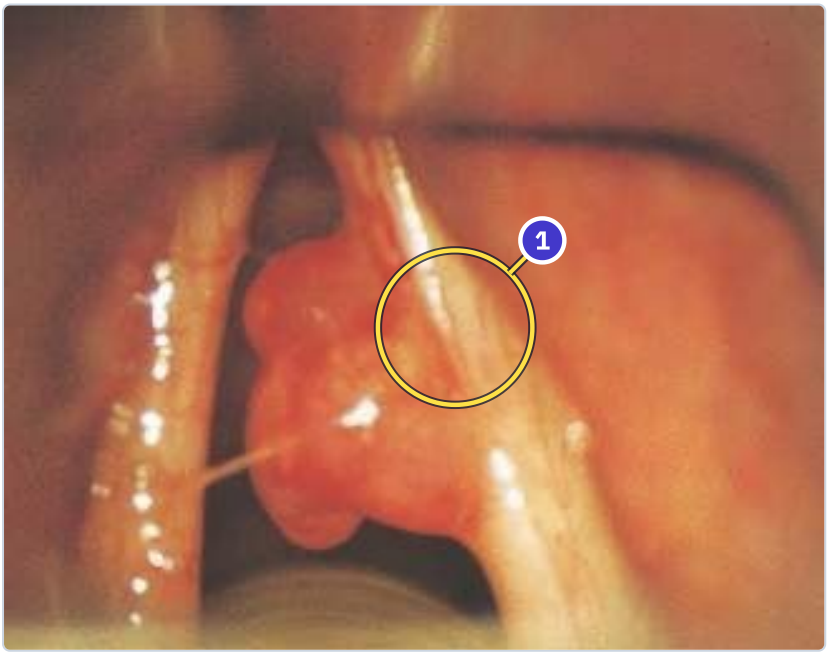


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 771

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pólipo

DIAGNÓSTICO

Pólipo vocal

Lesión unilateral.

CONDUCTA INICIAL

Cirugía.

6.03.1.010 Disfonías crónicas

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Nódulos.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 82** Tema 14.16

Clase 14.16 en video

41 TEMA 14.16 · DISFONÍA CRÓNICA Y PATOLOGÍA BENIGNA DE CUERDAS VOCALES

ENDOSCOPÍA

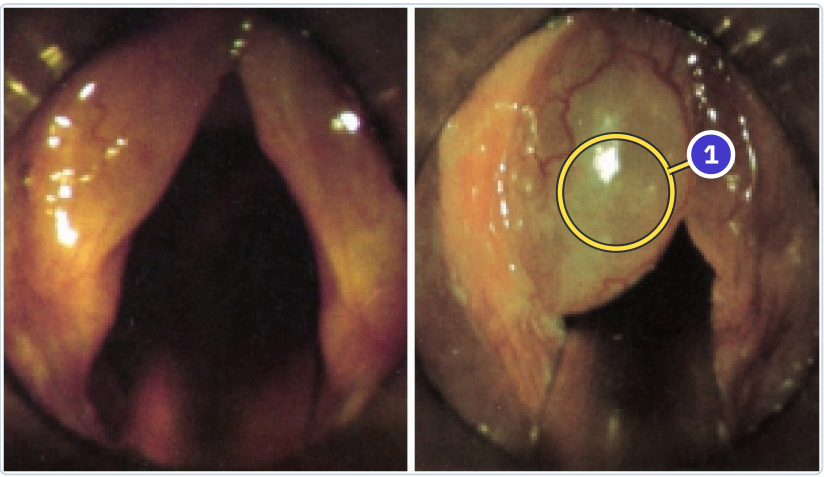


Imagen: Color Atlas of ENT Diagnosis (Bull), p. 229

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cuerda edematosa

DIAGNÓSTICO

Edema de Reinke

Cuerdas edematosas y translúcidas en un fumador.

CONDUCTA INICIAL

Dejar de fumar.

6.03.1.010 Disfonías crónicas

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cáncer.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2019 · P2 «Un paciente de 58 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disfonía de 3 semanas de evolución, asociada a ligera odinofagia. Al examen…» → **Nasofibrolaringoscopía**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA p. 83 Tema 14.16

Clase 14.16 en video

42 TEMA 14.17 · CROUP / LARINGITIS OBSTRUCTIVA VS EPIGLOTITIS AGUDA

IMAGEN RADIOLÓGICA

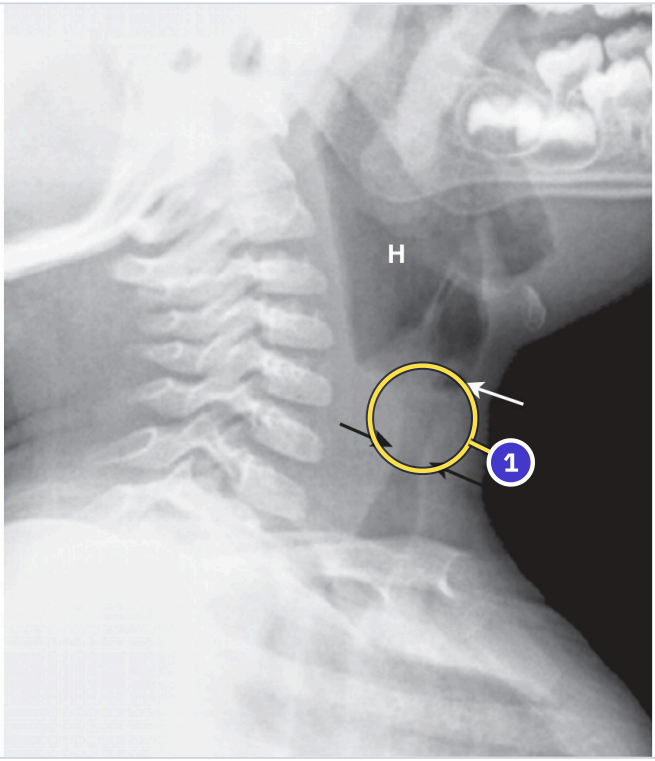


Imagen: Herring, Learning Radiology, 4.ª ed., p. 404

QUÉ TIENES QUE VER

1 Subglotis estrecha

DIAGNÓSTICO

Croup

Estrechamiento subglótico (flechas).

CONDUCTA INICIAL

Dexametasona; adrenalina nebulizada si es moderado-grave.

2.01.1.025 Laringitis

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Epiglotitis: signo del pulgar.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P133 «Un lactante de 12 meses presenta un cuadro de tos, rinorrea y fiebre hasta 38,8°C de 24 horas de evolución, a lo que hoy se agregó dificultad…» → **Laringitis aguda obstructiva**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA p. 86 Tema 14.17

Clase 14.17 en video

43 TEMA 14.17 · CROUP / LARINGITIS OBSTRUCTIVA VS EPIGLOTITIS AGUDA

ENDOSCOPÍA

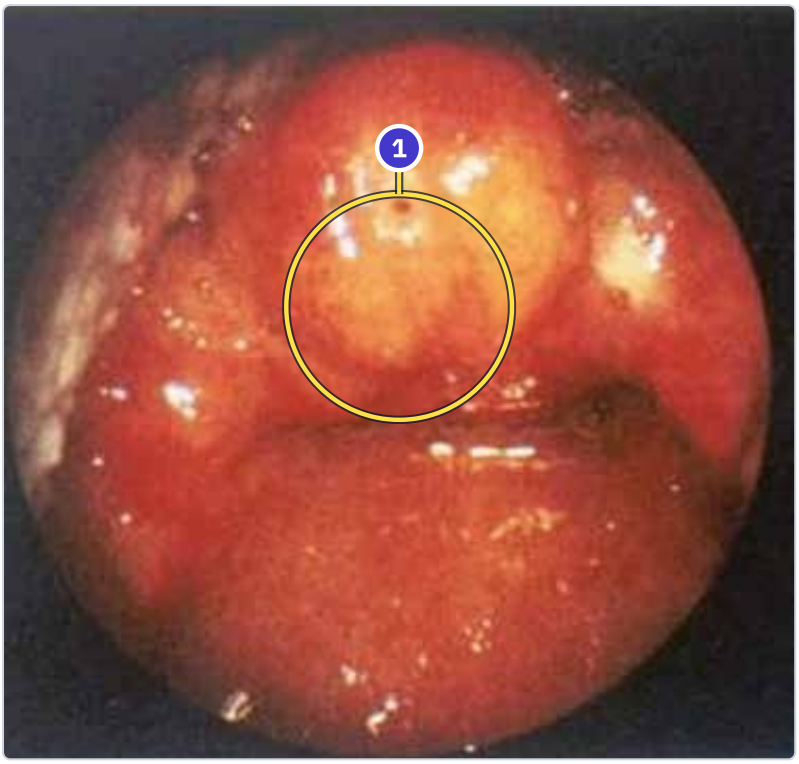


Imagen: Manual CTO Pediatría, p. 50

QUÉ TIENES QUE VER

1 Epiglotis

DIAGNÓSTICO

Epiglotitis

Epiglotis roja cereza.

CONDUCTA INICIAL

No examinar la faringe: vía aérea en pabellón.

2.01.2.018 Obstrucción de vía aérea superior

Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Croup.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 86** Tema 14.17

Clase 14.17 en video

44 TEMA 14.17 · CROUP / LARINGITIS OBSTRUCTIVA VS EPIGLOTITIS AGUDA

IMAGEN RADIOLÓGICA

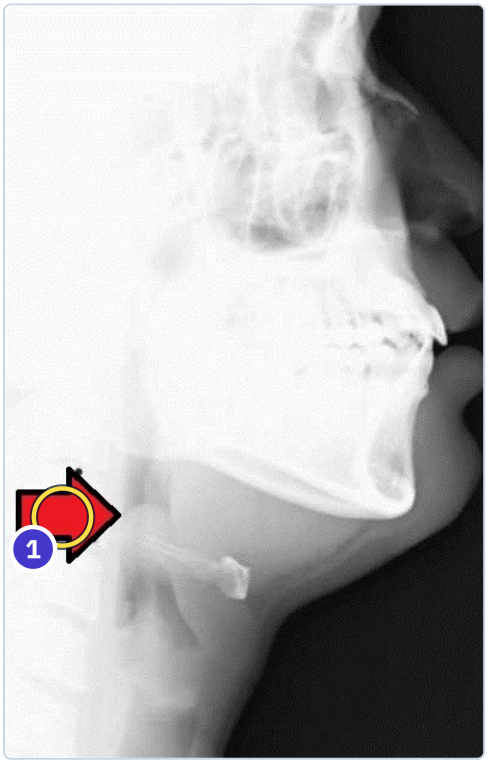


Imagen: Wikimedia Commons, CC0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Epiglotis

DIAGNÓSTICO

Signo del pulgar

Epiglotis engrosada en la Rx lateral (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Asegurar la vía aérea.

2.01.2.018 Obstrucción de vía aérea superior

Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Croup.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 86** Tema 14.17

Clase 14.17 en video

45 TEMA 14.17 · CROUP / LARINGITIS OBSTRUCTIVA VS EPIGLOTITIS AGUDA

ENDOSCOPÍA

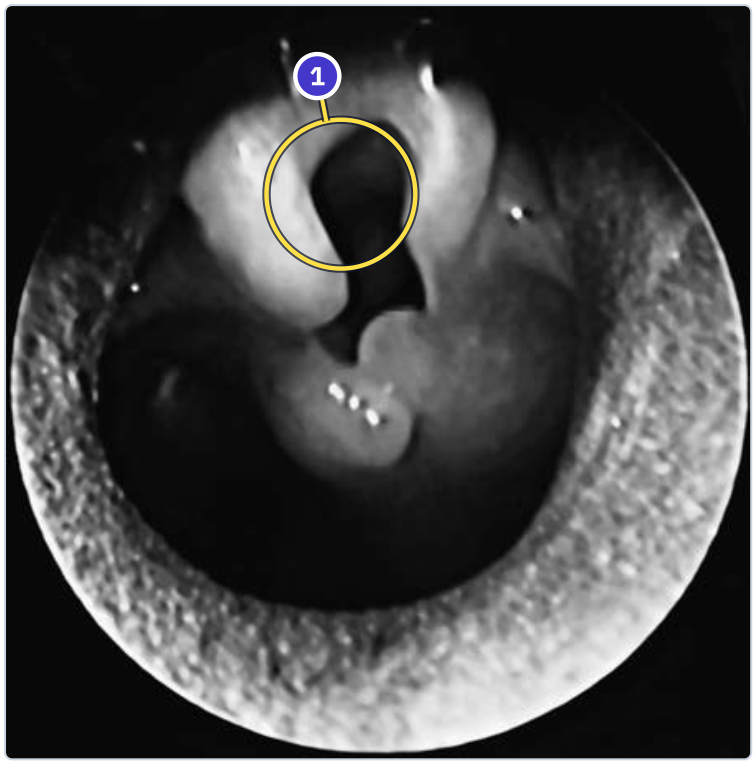


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 3228

QUÉ TIENES QUE VER

1 Epiglotis en omega

DIAGNÓSTICO

Laringomalacia

Epiglotis en omega que colapsa en la inspiración.

CONDUCTA INICIAL

Leve: se resuelve antes de los 2 años; control.

6.03.1.013	Estridor laríngeo	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
2.01.1.117	Estridor congénito	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Traqueomalacia.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2024 · P86 «Lactante con estridor inspiratorio desde el nacimiento, que empeora al llorar y mejora en decúbito prono. ¿Cuál es la causa más probable?» → **Laringomalacia**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA
p. 88
Tema 14.17

Clase 14.17 en video

46 TEMA 14.18 · CUERPOS EXTRAÑOS EN ORL

IMAGEN RADIOLÓGICA

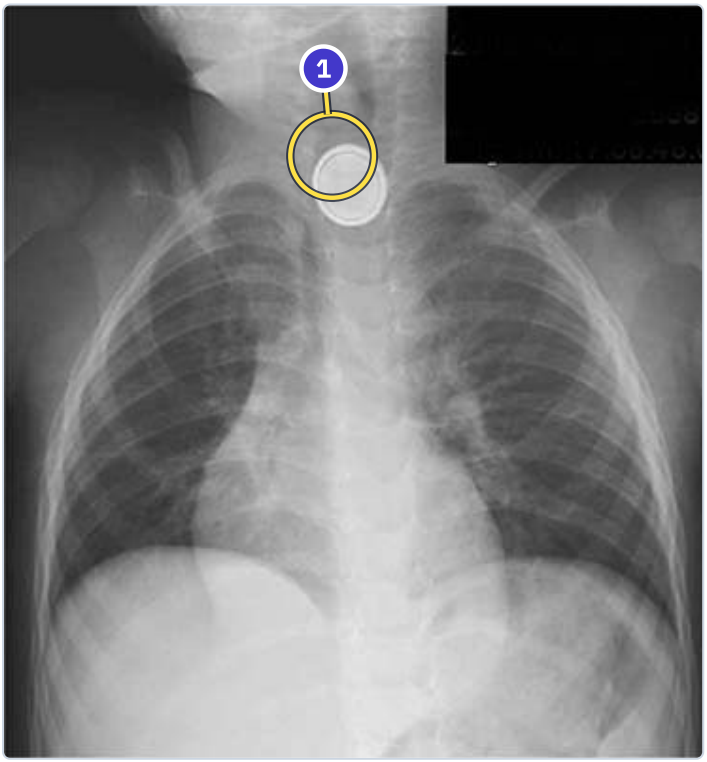


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 490

QUÉ TIENES QUE VER

1 Doble contorno

DIAGNÓSTICO

Pila de botón

Doble contorno en la Rx.

CONDUCTA INICIAL

Extracción endoscópica urgente.

6.03.2.008	Cuerpo extraño en el esófago	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Moneda: sin doble contorno.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA
p. 95
Tema 14.18

Clase 14.18 en video

47 TEMA 14.18 · CUERPOS EXTRAÑOS EN ORL

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 46.10

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cuerpo extraño

DIAGNÓSTICO

Cuerpo extraño en el conducto

Objeto en el conducto auditivo.

CONDUCTA INICIAL

Extracción; pila o insecto vivo con cuidado.

6.03.2.007 Cuerpo extraño en el oído
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

6.03.5.006 Extracción de cuerpo extraño del oído
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Tapón de cerumen.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA
p. 95
Tema 14.18

Clase 14.18 en video

48 TEMA 14.18 · CUERPOS EXTRAÑOS EN ORL

IMAGEN RADIOLÓGICA

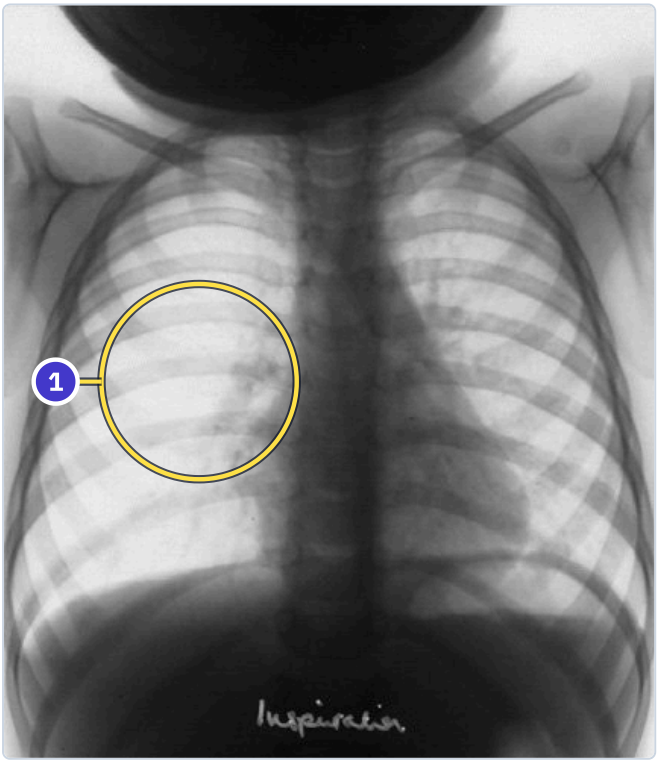


Imagen: CXR, Fig. 14.13 (a)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pulmón

DIAGNÓSTICO

Cuerpo extraño bronquial: inspiración

Rx de tórax en inspiración.

CONDUCTA INICIAL

Rx en espiración: atrapamiento aéreo; broncoscopía.

6.03.2.009 Cuerpo extraño en vía aérea
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Asma.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2017 · P94 «Un paciente de 26 años, con antecedente de daño cerebral severo, desde hace 2 días presenta sialorrea, tos áfona, estridor inspiratorio y…» → **Cuerpo extraño laríngeo**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA
p. 95
Tema 14.18

Clase 14.18 en video

49 TEMA 14.19 · PATOLOGÍA DE GLÁNDULAS SALIVALES

IMAGEN RADIOLÓGICA

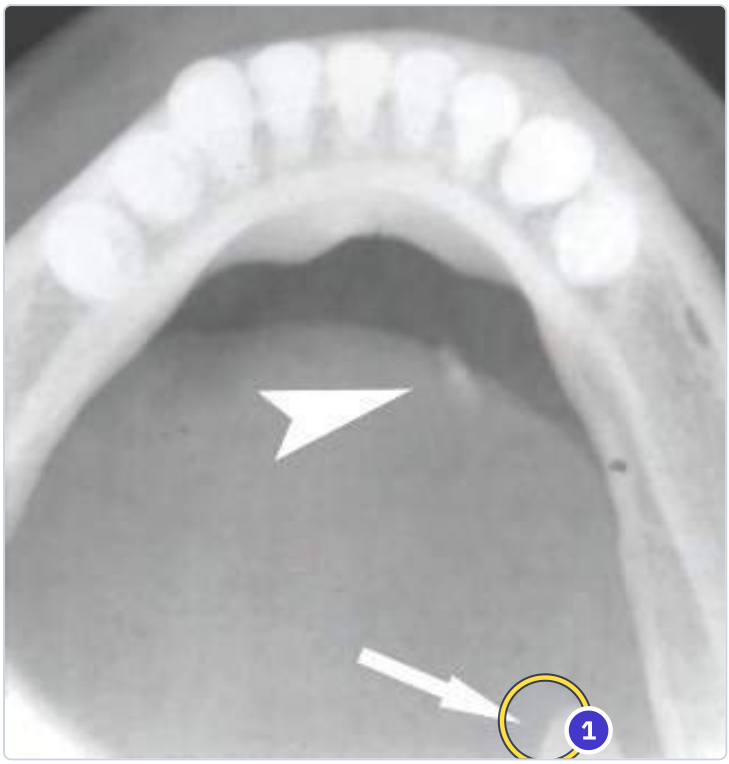


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 802

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cálculo

DIAGNÓSTICO

Cálculo en el conducto de Wharton

Opacidad en el piso de la boca (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Extracción.

6.03.1.023 Patología de glándulas salivales

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Tumor.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA p. 99 Tema 14.19

Clase 14.19 en video

50 TEMA 14.19 · PATOLOGÍA DE GLÁNDULAS SALIVALES

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 802

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pus

DIAGNÓSTICO

Sialadenitis supurada

Pus por el conducto.

CONDUCTA INICIAL

Antibióticos, hidratación y sialogogos.

6.03.1.023 Patología de glándulas salivales

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Parotiditis viral.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P168 «Un niño de 6 años es traído por su madre, dado que desde hace 2 horas comenzó con dolor y aumento de volumen en la zona paro`dea derecha. Al…» → **Litiasis del conducto de Stensen**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA p. 99 Tema 14.19

Clase 14.19 en video

51 TEMA 14.19 · PATOLOGÍA DE GLÁNDULAS SALIVALES

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 809

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa parotídea

DIAGNÓSTICO

Tumor parotídeo benigno

Aumento de volumen preauricular.

CONDUCTA INICIAL

Adenoma pleomorfo: parotidectomía superficial.

6.03.1.023	Patología de glándulas salivales	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.1.001	Patología glándulas salivales	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Adenopatía.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 99** Tema 14.19

Clase 14.19 en video

52 TEMA 14.20 · CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bates 12.ª ed., Fig. 7-71

QUÉ TIENES QUE VER

1 Tumor

DIAGNÓSTICO

Carcinoma de lengua

Lesión ulcerada y leucoplásica.

CONDUCTA INICIAL

Biopsia.

6.03.1.004	Cáncer de boca, labios y orofaringe	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Úlcera traumática: cura en 2 semanas.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 103** Tema 14.20

Clase 14.20 en video

53 TEMA 14.20 · CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

FOTO CLÍNICA

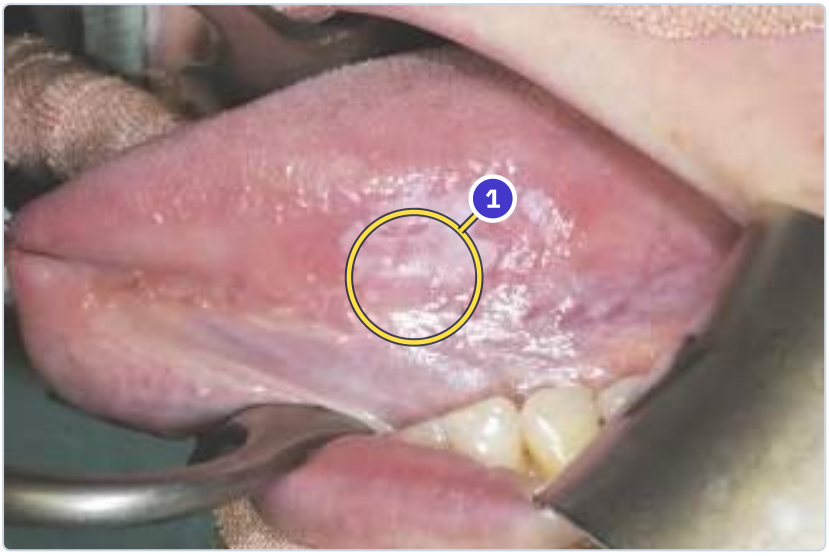


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 48.11 (a)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Placa blanca

DIAGNÓSTICO

Leucoplaquia

Placa blanca que no se desprende.

CONDUCTA INICIAL

Biopsia.

6.03.1.004 Cáncer de boca, labios y orofaringe
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Candidiasis: se desprende.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 103** Tema 14.20

Clase 14.20 en video

54 TEMA 14.20 · CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

FOTO CLÍNICA



Imagen: Open-i (NLM), CC BY

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa

DIAGNÓSTICO

Masa cervical lateral

Aumento de volumen cervical.

CONDUCTA INICIAL

Adulto fumador: buscar primario de cabeza y cuello.

6.03.1.015 Masa cervical
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

4.01.1.032 Masa cervical y tumores del cuello
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Quiste branquial.

PREGUNTA REAL **Julio 2016 · P116** «Un paciente de 25 años de edad, sin patologías previas, presenta desde hace 4 años aumento de volumen cervical lateral, que ha ido creciendo. Al…» → **Quiste branquial**

TOMO OTORRINOLARINGOLOGÍA **p. 103** Tema 14.20

Clase 14.20 en video

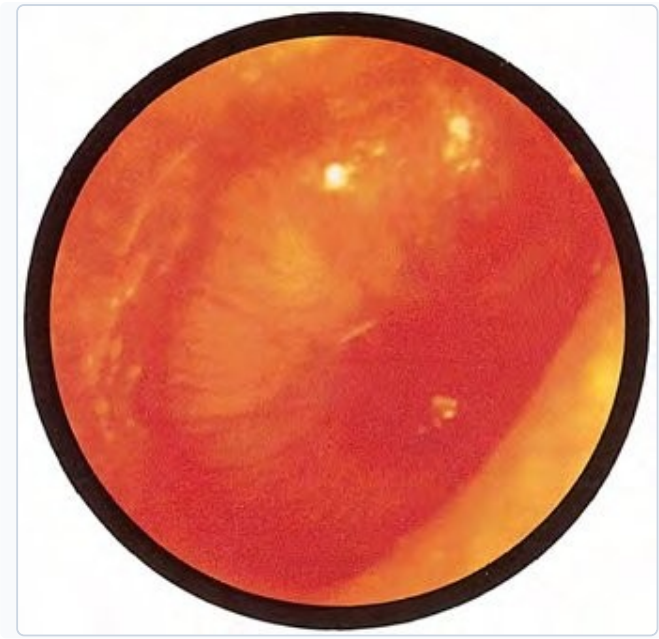
Parecidas pero distintas

Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS Tímpano normal vs OMA



VS



A **Tímpano normal**

- Gris perla, translúcido

Ficha n.° 01 · p. 4

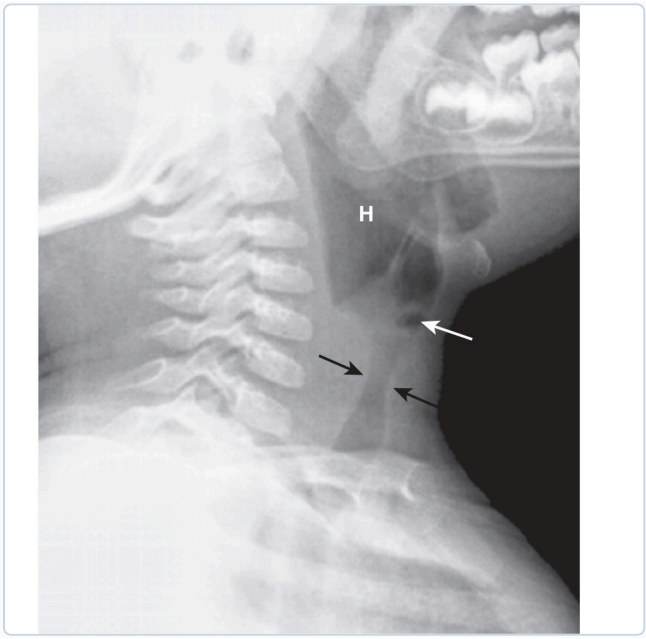
B **Otitis media aguda**

- Rojo y abombado

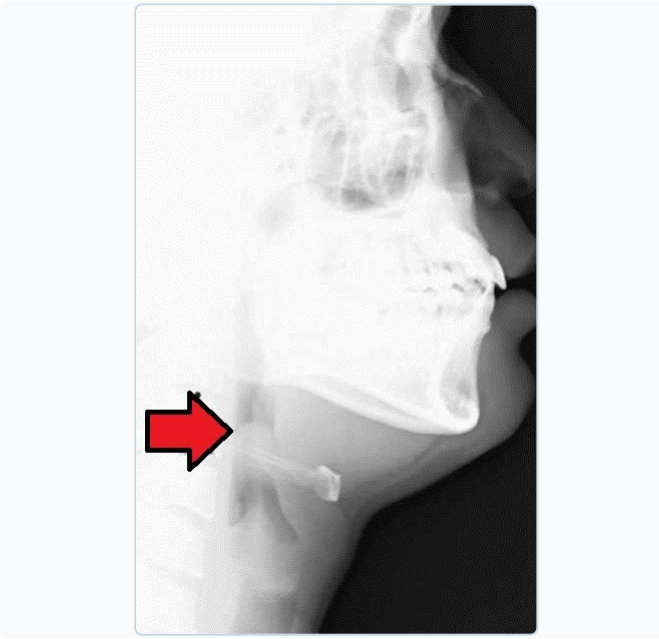
Ficha n.° 02 · p. 4

LA DIFERENCIA El abombamiento define la OMA.

PARECIDAS PERO DISTINTAS Croup vs epiglotitis



VS



A **Croup**

- Subglotis en campanario

Ficha n.° 42 · p. 24

B **Signo del pulgar**

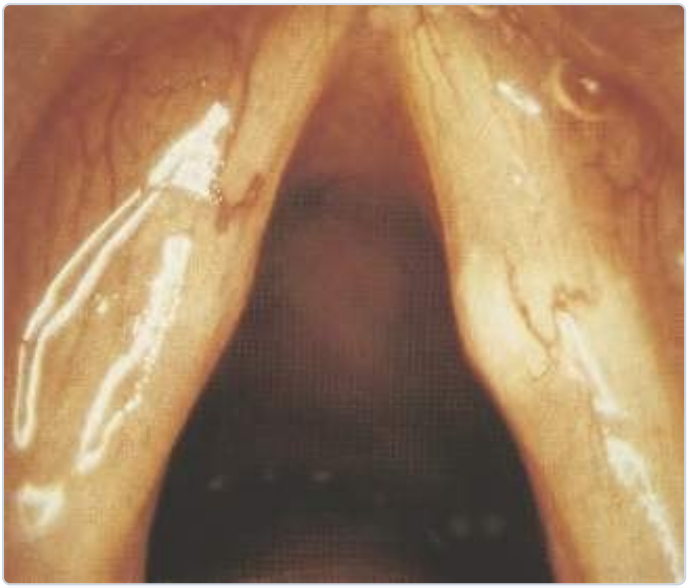
- Signo del pulgar

Ficha n.° 44 · p. 25

LA DIFERENCIA La epiglotitis es una emergencia de vía aérea.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Nódulos vs pólipo



VS



A Nódulos vocales

- Bilaterales

Ficha n.° 39 · p. 23

B Pólipo vocal

- Unilateral

Ficha n.° 40 · p. 23

LA DIFERENCIA Los nódulos responden a fonoterapia.

Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.

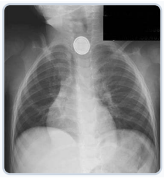


SIGNO DEL PULGAR

Epiglotis engrosada en la Rx lateral.

Se ve en: Epiglotitis.

Tomo p. 86 · Atlas: ficha n.° 44, p. 25



DOBLE CONTORNO

Halo en el borde del objeto.

Se ve en: Pila de botón.

Tomo p. 95 · Atlas: ficha n.° 46, p. 26

Índice por tipo de imagen

34	2	12	6
FOTO CLÍNICA	ESQUEMA	IMAGEN RADIOLÓGICA	ENDOSCOPÍA

Foto clínica · 34

01 Tímpano normal (14.1) 4
02 Otitis media aguda (14.1) 4
03 Otitis media con efusión (14.2) 5
04 Collera en el tímpano (14.2) 5
05 Perforación timpánica central (14.2) 6
06 Colesteatoma (14.2) 6
07 Otitis externa difusa (14.3) 7
08 Otomicosis (14.3) 7
09 Otohematoma (14.3) 8
10 Otitis externa maligna (14.3) 8
11 Mucormicosis rinoorbitaria (14.3) 9
12 Mastoiditis: pabellón despegado (14.4) 9
14 Prueba de Weber (14.5) 10
16 Audífono retroauricular (14.6) 11
18 Parálisis de Bell: lagoftalmos (14.8) 12
19 Comisura que no se eleva (14.8) 13
20 Ramsay Hunt: vesículas en la concha (14.8) 13
21 Facies de rinitis alérgica (14.9) 14
22 Celulitis periorbitaria por etmoiditis (14.10) 14
25 Fractura nasal: laterorrinia (14.12) 16
26 Hematoma septal bilateral (14.12) 16
27 Pólipo que llega a la orofaringe (14.12) 17
28 Faringitis sin exudado (14.13) 17
29 Placas en las criptas amigdalinas (14.13) 18
30 Amigdalitis con exudado (14.13) 18
31 Absceso periamigdalino (14.14) 19
36 Facies adenoidea (14.15) 21
37 Amígdalas grado 4 (14.15) 22
47 Cuerpo extraño en el conducto (14.18) 27
50 Sialadenitis supurada (14.19) 28
51 Tumor parotídeo benigno (14.19) 29
52 Carcinoma de lengua (14.20) 29
53 Leucoplaquia (14.20) 30
54 Masa cervical lateral (14.20) 30

Esquema · 2

17 Maniobra de Epley (14.7) 12
24 Irrigación del tabique (14.11) 15

Imagen radiológica · 12

13 Mastoiditis coalescente en la TAC (14.4) 10
15 Schwannoma vestibular en la RM (14.6) 11
23 Absceso subperióstico en la TAC (14.10) 15
32 Absceso retrofaríngeo en la Rx lateral (14.14) 19
33 Absceso retrofaríngeo en la TAC (14.14) 20
34 Absceso retrofaríngeo: Rx y TC (14.14) 20
35 Absceso parafaríngeo (14.14) 21
42 Croup (14.17) 24
44 Signo del pulgar (14.17) 25
46 Pila de botón (14.18) 26
48 Cuerpo extraño bronquial: inspiración (14.18) 27
49 Cálculo en el conducto de Wharton (14.19) 28

Endoscopía · 6

38 Carcinoma de cuerda vocal (14.16) 22
39 Nódulos vocales (14.16) 23
40 Pólipo vocal (14.16) 23
41 Edema de Reinke (14.16) 24
43 Epiglotitis (14.17) 25
45 Laringomalacia (14.17) 26

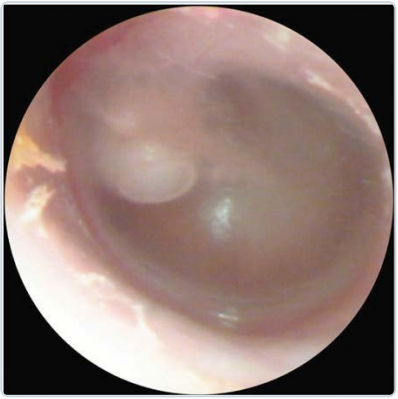
Autoevaluación

4 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

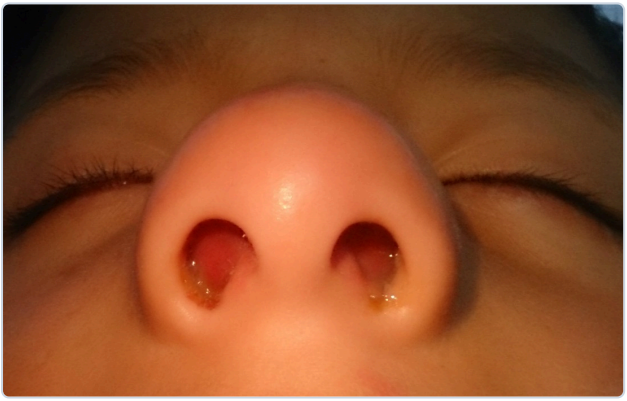
1 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



2 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



3 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



4 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



Soluciones de la autoevaluación

N.º	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
1	**Otitis media aguda**	Tímpano abombado	02 · p. 4
2	**Colesteatoma**	Masa nacarada	06 · p. 6
3	**Hematoma septal bilateral**	Tabique abombado	26 · p. 16
4	**Absceso periamigdalino**	Pilar abombado	31 · p. 19